



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Discharge Planning Berbasis Family Centered Care (FCC) Pada Pasien Stroke Iskemik

Ns. Nida Laila, S.Kep.
Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Mat.
Dr. Ns. Chanif, S.Kep., MNS.
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes.
Ns. Winda Yuniarsih, S.Kep., M.Kep., Sp.KepMB.
Ns. Dwi Astuti, S.Kep., M.Kep.



Discharge Planning

Berbasis Family Centered Care (FCC)

Pada Pasien Stroke Iskemik

Ns. Nida Laila, S.Kep.

Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Mat.

Dr. Ns. Chanif, S.Kep., MNS.

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes.

Ns. Winda Yuniarsih, S.Kep., M.Kep., Sp.KepMB.

Ns. Dwi Astuti, S.Kep., M.Kep.



Discharge Planning Berbasis Family Centered Care (FCC) Pada Pasien Stroke Iskemik

Ns. Nida Laila, S.Kep.

Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Mat.

Dr. Ns. Chanif, S.Kep., MNS.

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes.

Ns. Winda Yuniarsih, S.Kep., M.Kep., Sp.KepMB.

Ns. Dwi Astuti, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN : 978-634-7294-65-4

Terbit : Juli, 2025



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal

Tiktok @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Discharge planning berbasis Family Centered Care (fcc) pada pasien Stroke Iskemik / Ns. Nida Laila, S.Kep, Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Mat, Dr. Ns. Chanif, S.Kep., MNS, Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes [dan 2 lainnya]
PUBLIKASI DESKRIPSI FISIK	Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025
IDENTIFIKASI SUBJEK	83 halaman ; 30 cm ISBN 978-634-7294-65-4 Penyakit serebrovaskular
KLASIFIKASI PERPUSNAS ID	616.81 [23] https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1247652



Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ***Discharge Planning* berbasis *Family Centered Care* Pada Pasien Stroke Iskemik**. Buku ini disusun sebagai panduan praktis dalam melaksanakan perencanaan pemulangan bagi pasien stroke iskemik sehingga keluarga dapat mempersiapkan perawatan lanjutan setelah keluar dari Rumah Sakit.

Buku ini berfokus pada pengetahuan, pemahaman perawat dan implementasi dalam membantu meningkatkan fungsi neurologis dan kualitas hidup pasien stroke iskemik. Pendekatan ini dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi perawat sebagai bahan pedoman dalam melakukan perencanaan pemulangan yang efektif dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perawatan. Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan buku ini.

Semarang, Juli 2025

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	viii

BAB 1 Stroke Iskemik dan Pentingnya *Discharge*

<i>Planning</i>	1
A. Mengetahui Lebih Dekat Stroke Iskemik.....	1
B. Apa Saja yang Menjadi Tujuan Buku Ini.....	4
C. Manfaat Buku Ini.....	4

BAB 2 Konsep Stroke

A. Mengetahui Stroke Iskemik	6
1. Apa itu Stroke?.....	6
2. Stroke Iskemik dalam Angka	7
3. Jenis Stroke yang Perlu Diketahui	7
4. Penyebab Stroke Iskemik.....	8
5. Faktor Risiko Stroke Iskemik.....	9
6. Apa yang Terjadi di Otak?	12
7. Kenali Tanda dan Gejala Stroke Iskemik	13
8. Penanganan Stroke Iskemik: Langkah Cepat yang Menyelamatkan Otak.....	14
9. Mencegah Stroke Iskemik: Langkah Kecil untuk Hasil Besar	24
10. Komplikasi Stroke Iskemik: Dampak yang Perlu Diwaspadai.....	25
11. Merawat Pasien Stroke Di Rumah: Langkah Sederhana, Hasil Maksimal	26
B. Status Neurologis: Mengukur Fungsi Sistem Saraf Pasien Stroke	32
1. Apa itu Status Neurologis?.....	32

2. Menentukan Derajat Kerusakan Neurologis.....	33
3. Penilaian dalam Skala <i>National Institutes of Health Stroke Scale</i> (NIHSS)	33
C. Kualitas Hidup (<i>Quality of Life</i>)	34
1. Definisi Kualitas Hidup.....	34
2. Elemen Kualitas Hidup.....	34
3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Hidup Pasien Stroke	35

BAB 3 Konsep *Discharge Planning*. Persiapan Pulang

Pasien Stroke	38
A. Apa itu <i>Discharge Planning</i> ?	38
B. Tujuan <i>Discharge Planning</i>	39
C. Mengapa <i>Discharge Planning</i> Penting?.....	40
D. Faktor -faktor yang Memengaruhi <i>Discharge Planning</i>	40
E. Prinsip Penting dalam <i>Discharge Planning</i>	41
F. Elemen dalam <i>Discharge planning</i>	42
G. Peran Perawat dalam <i>Discharge Planning</i>	43

BAB 4 Konsep *Family Centered Care* (FCC): Merangkul

Keluarga dalam Perawatan Pasien.....	46
A. Apa itu <i>Family Centered Care</i> ?.....	46
B. Tujuan <i>Family Centered Care</i>	47
C. Prinsip <i>Family Centered Care</i> yang Wajib Diterapkan	47
D. Peran Keluarga dalam Perawatan Pasien Stroke.....	48
E. Peran Perawat dan Keluarga dalam <i>Family Centered Care</i>	48
F. Integrasi <i>Family Centered Care</i> dalam <i>Discharge Planning</i> untuk Pasien Stroke	49

BAB 5 Implementasi <i>Discharge Planning</i> Berbasis <i>Family Centered Care</i> (FCC)	52
A. Tahapan Dalam <i>Discharge Planning</i> Berbasis FCC	53
B. Manfaat Implementasi <i>Family Centered Care</i> untuk Pasien Stroke.....	57
C. Pemantauan Perawatan Pasca Stroke Di Rumah	58
BAB 6 Kesimpulan	60
Daftar Pustaka	67

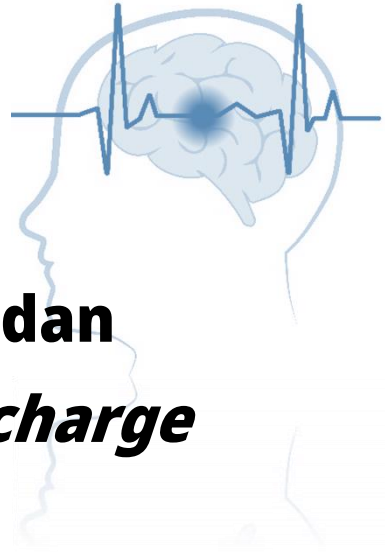
Daftar Gambar

Gambar 2.1	Perbedaan Stroke Iskemik dan Stroke Hemoragik .8
Gambar 2.2	Gambaran Stroke Iskemik 8
Gambar 2.3	Patofisiologi Risiko Diabetes Mellitus pada Stroke Iskemik..... 11
Gambar 2.4	Penilaian Tanda-Tanda Stroke 16
Gambar 2.5	Obat Anti Hipertensi 18
Gambar 2.6	Obat Kolesterol 18
Gambar 2.7	Obat Trombolisis..... 18
Gambar 2.8	Antikoagulan Injeksi 19
Gambar 2.9	Antikoagulan Oral 19
Gambar 2.10	Cairan Osmotik Deuretik 20
Gambar 2.11	Rehabilitasi Paska Stroke 21
Gambar 2.12	Okupasi Terapi 23
Gambar 2.13	Ilustrasi Pusat (Central Illustration)..... 25
Gambar 2.14	Dukungan Emosional 29

Daftar Tabel

Tabel 5.1	Diagnosa Keperawatan pada Pasien Stroke (SDKI) 54
Tabel 5.2	Ceklist Harian Perawatan Di Rumah 58
Tabel 5.3	Catatan Perkembangan Kesehatan..... 59

BAB 1



Stroke Iskemik dan Pentingnya *Discharge Planning*

A. Mengenal Lebih Dekat Stroke Iskemik

Stroke bukanlah istilah yang asing bagi kebanyakan orang. Namun, tahukah Anda bahwa stroke iskemik merupakan salah satu penyebab utama kematian dan disabilitas jangka panjang di seluruh dunia? Stroke jenis ini terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke otak. Akibatnya, jaringan otak mengalami kerusakan yang berdampak pada gangguan fungsi tubuh seperti kemampuan gerak, rasa, hingga daya ingat dan konsentrasi.

Gangguan fungsi akibat stroke iskemik tidak hanya menjadi beban bagi pasien saja, tetapi juga keluarga yang merawat. Beban ini mencakup aspek emosional, psikologis, hingga ekonomi. Pasien yang mengalami stroke seringkali bergantung pada bantuan keluarga dalam menjalankan

aktivitas sehari-hari, yang tentunya membutuhkan kesiapan dan pengetahuan dari pihak keluarga.

Secara global, prevalensi stroke terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia, stroke menempati posisi ketiga dalam hal pembiayaan kesehatan setelah penyakit jantung dan kanker, dengan total biaya mencapai Rp 3,23 triliun pada tahun 2022, meningkat dari Rp 1,91 triliun pada tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa stroke iskemik tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menjadi beban besar bagi sistem kesehatan nasional. Selain mortalitas dan morbiditas yang tinggi, angka kekambuhan dan rehospitalisasi juga menunjukkan bahwa manajemen pasca-rawat inap masih belum optimal.

Mengapa Discharge Planning Penting?

Dalam praktik klinis, proses pemulangan pasien stroke sering kali belum dirancang secara sistematis dan komprehensif. Sebagian besar perawatan stroke tidak melibatkan keluarga secara aktif sejak awal perawatan, sehingga keluarga kurang siap dalam menghadapi kondisi pasien yang kompleks di rumah. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan peningkatan stres keluarga, kesalahan dalam perawatan di rumah, dan berujung pada komplikasi atau bahkan rehospitalisasi.

Menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), perencanaan pemulangan seharusnya dimulai sejak tahap awal asesmen dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, edukasi, hingga evaluasi. *Discharge planning* yang dilakukan secara

terstruktur dan berkesinambungan dapat meningkatkan kesiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi fase pasca-rawat inap, mengurangi angka komplikasi, dan mempercepat proses pemulihan. Namun, dalam praktiknya, implementasi *discharge planning* di beberapa rumah sakit masih terbatas pada aspek administratif tanpa pendekatan yang holistik.

Family Centered Care (FCC): Solusi Efektif untuk Stroke

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas *discharge planning* adalah model *Family Centered Care* (FCC). FCC menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam perawatan pasien dengan fokus pada kolaborasi, edukasi, dan dukungan emosional (Indrawati & Fitryasari, 2021). Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mempercepat pemulihan fungsi neurologis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penyusunan buku *discharge planning* berbasis *Family Centered Care* pada pasien stroke iskemik menjadi penting untuk memberikan panduan yang terstruktur bagi tenaga kesehatan dalam menyusun rencana pemulangan yang efektif dan holistik. buku ini diharapkan dapat menjadi alat edukatif yang memberdayakan keluarga dalam memberikan dukungan optimal bagi pasien, mencegah komplikasi pasca-rawat, serta mempercepat pemulihan fungsi dan kualitas hidup pasien stroke iskemik.

B. Apa Saja yang Menjadi Tujuan Buku Ini

1. Tujuan Utama

Buku ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga serta keterampilan perawat dalam melakukan perawatan berkelanjutan dari rumah sakit ke rumah pasien stroke iskemik.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit stroke iskemik dan tatalaksananya.
- b. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan dan keluarga pasien terhadap pendekatan *Family Centered Care* (FCC).
- c. Meningkatkan peran serta keluarga dalam perawatan setelah pasien keluar dari rumah sakit.
- d. Meningkatkan proses pemulihan pasien melalui perencanaan pulang terstruktur dan komprehensif
- e. Meningkatkan status neurologis dan kualitas hidup pasien stroke iskemik.

C. Manfaat Buku Ini

1. Bagi pasien dan keluarga

Buku ini membantu keluarga memahami peran pentingnya dalam proses perawatan pasien stroke setelah pulang dari rumah sakit, meningkatkan kesiapan keluarga dalam merawat pasien di rumah melalui informasi yang mudah dipahami dan aplikatif serta dapat mengurangi risiko komplikasi dan rehospitalisasi akibat kurangnya pengetahuan pasca-pulang.

2. Bagi tenaga Kesehatan

Buku ini diharapkan menjadi panduan praktis dan teoritis dalam pelaksanaan discharge planning yang terstruktur dan berpusat pada keluarga serta meningkatkan ketrampilan komunikasi dan kolaborasi antar profesi dan keluarga

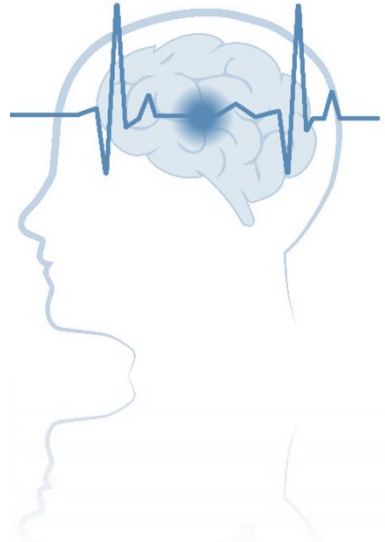
3. Bagi Rumah Sakit

Buku ini diharapkan dapat mendukung standar akreditasi rumah sakit terkait keselamatan pasien dan pelayanan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui discharge planning yang terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem informasi rumah sakit.

Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu menjadi alat yang mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien stroke iskemik dan keluarga yang merawatnya.

BAB 2

Konsep Stroke



A. Mengenal Stroke Iskemik

1. Apa itu Stroke?

Menurut *American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA)*, stroke didefinisikan sebagai sindrom defisit neurologis akut yang disebabkan oleh kerusakan pada otak, medulla spinalis, dan retina yang dapat disebabkan oleh faktor vascula. Stroke merupakan sindrom klinis yang didefinisikan sebagai defisit neurologis fokal akut yang disebabkan oleh infark atau perdarahan pada sistem saraf pusat yang terjadi secara tiba-tiba, dengan gejala yang berlangsung lebih dari 24 jam hingga mengakibatkan kematian sebelum 24 jam.

Stroke iskemik yang dikenal sebagai stroke infark atau stroke tanpa perdarahan adalah kondisi ketika terjadi gangguan aliran darah ke otak yang disebabkan oleh adanya emboli atau trombus sehingga menyebabkan area otak yang tidak mendapat suplai darah tidak berfungsi dan dapat mengalami kematian sel.

2. Stroke Iskemik dalam Angka

Stroke iskemik merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia. Menurut data *World Stroke Organization* (WSO), lebih dari 13,7 juta orang menderita stroke, dan sekitar 5,5 juta orang meninggal karena stroke. Data *Global Stroke Fact Sheet* mencatat angka kematian akibat stroke sebanyak 6.552.724 orang dan terdapat 143.232.184 orang mengalami kecacatan akibat stroke yang pernah dialami. Di Indonesia stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, yakni sebesar 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari total kematian. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1.000 penduduk. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) kasus stroke di Indonesia meningkat 12,1% pada tahun 2020 menjadi 14,9% pada tahun 2021.

3. Jenis Stroke yang Perlu Diketahui

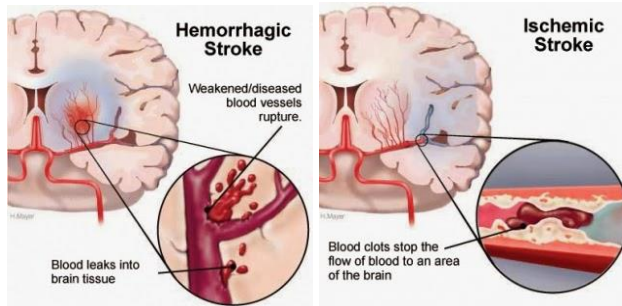
Secara umum stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik atau stroke non hemoragik dan stroke hemoragik.

a. Stroke Iskemik

Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak tersumbat yang disebabkan adanya thrombus dan emboli (bekuan darah/plak) pada pembuluh darah. Sumbatan akan menyebabkan gangguan aliran darah ke otak sehingga terjadi kematian.

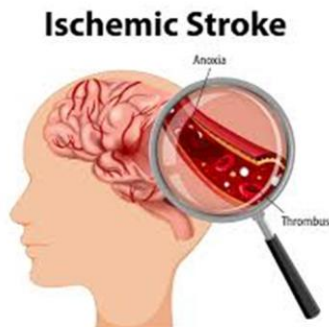
b. Stroke Hemoragik (stroke perdarahan)

Stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan adanya perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid sehingga menyebabkan kerusakan pada otak dan mengganggu fungsi saraf.



Gambar 2.1 Perbedaan Stroke Iskemik dan Stroke Hemoragik

4. Penyebab Stroke Iskemik



Gambar 2.2 Gambaran Stroke Iskemik

Stroke iskemik disebabkan oleh adanya thrombus dan emboli yang menyebabkan gangguan aliran darah ke otak sehingga terjadi kematian jaringan otak.

Thrombus pada pembuluh darah sebagai akibat dari aterosklerosis, diseksi arteri, *displasia*

fibromuskular, atau kondisi inflamasi. Sedangkan emboli disebabkan oleh adanya gumpalan darah berasal dari jantung dan bagian lain dari sirkulasi.

5. Faktor Risiko Stroke Iskemik

Faktor risiko stroke iskemik dikelompokkan menjadi faktor yang dapat dirubah dan faktor yang tidak dapat dirubah.

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu:

1) Usia

Risiko stroke meningkat seiring dengan penambahan usia. Namun stroke juga dapat terjadi pada usia muda, hal ini berkaitan dengan adanya faktor keturunan, gaya hidup atau karena faktor medis tertentu. Pada usia 55 tahun ke atas memiliki resiko 3,23 kali lebih besar untuk mengalami stroke dibandingkan pada usia kurang dari 55 tahun. Semakin bertambah usia mengakibatkan perubahan struktur dan penurunan fungsi organ tubuh, termasuk penurunan elastisitas pembuluh darah otak yang dapat meningkatkan terjadinya stroke.

2) Jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki memiliki risiko stroke lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan risiko 2,04 kali lebih besar. Risiko yang lebih tinggi pada laki-laki disebabkan oleh karena hormon testosteron yang dapat meningkatkan kadar LDL dalam darah. Namun, pada perempuan risiko stroke akan meningkat setelah memasuki masa menopause karena penurunan kadar estrogen.

3) Riwayat keluarga

Riwayat keluarga menjadi faktor signifikan terhadap kejadian stroke. Stroke terjadi akibat beberapa mekanisme faktor genetik, penyakit-penyakit yang ditemukan serta kelainan pembuluh darah bawaan yang sering tidak diketahui sebelum terjadinya stroke. Faktor keluarga menyumbang 30% dari faktor risiko stroke.

b. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu:

Beberapa faktor risiko yang dapat dirubah yaitu berhubungan pola hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik.

c. Faktor yang berhubungan dengan penyakit yaitu:

1) Hipertensi

Hipertensi merupakan faktor yang dominan terhadap kejadian stroke hemoragik dan stroke iskemik. Penderita hipertensi memiliki resiko 5,69 kali lebih besar mengalami stroke dibandingkan dengan yang tidak hipertensi. Tekanan darah tinggi merusak sel-sel dinding arteri, menyebabkan penumpukan lemak di arteri dan mengurangi elastisitas pembuluh darah yang dapat mengurangi ke aliran darah ke otak.

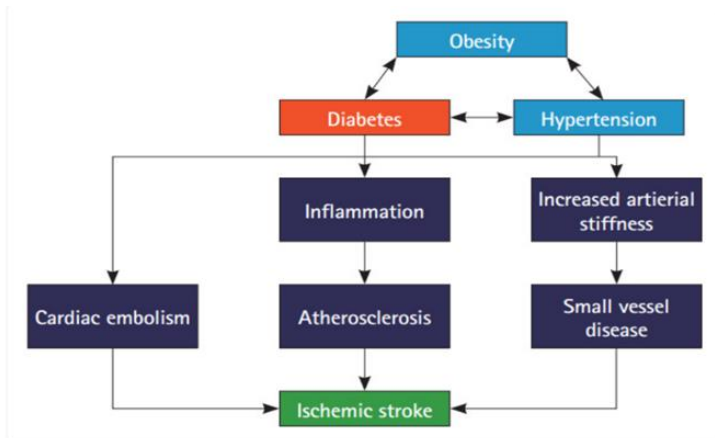
2) Penyakit kardiovaskuler

Penderita penyakit jantung memiliki resiko 2,57 kali lebih besar untuk menderita stroke. Penyakit jantung disebabkan oleh aterosklerosis, gangguan

irama jantung, defek katup jantung, dan pembesaran bilik jantung dapat menyebabkan pembentukan bekuan darah atau pecah pembuluh darah sehingga memicu terjadinya stroke

3) Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus dapat menyebabkan stroke melalui beberapa mekanisme yaitu kerusakan pembuluh darah yang diakibatkan oleh kadar gula darah yang tinggi secara kronis. Selain itu diabetes seringkali disertai dengan tekanan darah yang tinggi dan kadar kolesterol yang tinggi. Penderita diabetes melitus memiliki resiko 2,44 kali lebih besar untuk mengalami stroke.



Gambar 2.3 Patofisiologi Risiko Diabetes Mellitus pada Stroke Iskemik

(Mosenzon et al., 2023)

6. Apa yang Terjadi di Otak?

Stroke iskemik disebabkan oleh adanya sumbatan pembuluh darah akibat adanya thrombus atau emboli. Sumbatan ini mengakibatkan aliran darah ke otak terhambat sehingga otak kekurangan oksigen dan gangguan metabolisme. Jika kondisi ini berlangsung lama maka akan mengakibatkan kematian jaringan otak.

Proses thrombosis atau emboli menyebabkan sumbatan pembuluh darah sehingga aliran dah ke otak menurun. Penurunan *cerebral blood flow*(CBF) menyebabkan suplai oksigen ke otak berkurang sehingga mengakibatkan iskemia fokal maupun global. Ada dua lapisan jaringan serebrovaskular yang mengalami iskemik yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Pada lapisan dalam yang mengalami nekrosis, nilai CBF sekitar 10-12 ml/100 gram/menit, sedangkan lapisan iskemik yang dikelilingi oleh penumbra memiliki CBF sekitar 18-20 ml/100 gram/menit dan berisiko menjadi nekrosis dalam waktu beberapa jam. Jaringan penumbra memiliki CBF sekitar 60 ml/100 gram/menit. Selama kondisi patologis ini, autoregulasi otak menjadi terganggu. Ketika tekanan perfusi otak menurun, pembuluh darah otak membesar untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Namun jika penurunan tekanan perfusi melebihi kapasitas kompensasi otak, maka aliran darah ke otak akan berkurang sehingga terjadi peningkatan fraksi ekstraksi oksigen untuk mempertahankan pengiriman oksigen ke otak. Ketika aliran darah otak terus menurun, dalam hitungan menit, inti jaringan di area yang terkena ini

berkembang menjadi kerusakan irreversible, daerah dengan aliran darah yang berkurang akan terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi adenosin trifosfat (ATP), yang mengakibatkan berkurangnya penyimpanan energi.

Oklusi iskemik disebabkan oleh peristiwa trombotik dimana penyempitan pembuluh darah disebabkan oleh arterosklerosis. Arterosklerosis disebabkan oleh kadar kolesterol, pasien dengan high density lipoprotein (HDL) yang rendah dan kadar kolesterol low density lipoprotein yang tinggi memiliki risiko tinggi terjadi aterosklerosis serebri. Arterosklerosis dapat menyebabkan menurunnya elastisitas arteri besar sehingga memicu terjadinya hipertensi. Peningkatan tekanan darah pada pasien stroke bertahan beberapa lama setelah serangan stroke, hal ini dapat meningkatkan tekanan *intracranial* (ICP) oleh karena adanya edema cerebral pasca serangan stroke. Peningkatan ICP menurunkan tekanan perfusi serebral (CPP), sehingga menimbulkan hambatan dalam aliran darah serebral (CBF) ke otak dan menyebabkan iskemik.

7. Kenali Tanda dan Gejala Stroke Iskemik

Tanda dan gejala stroke iskemik bervariasi tergantung pada bagian otak yang cedera, ukuran lesi dan adanya sirkulasi kolateral. biasanya stroke terjadi secara mendadak.

Beberapa gejala yang umum terjadi akibat stroke iskemik adalah:

- a. *Paresthesia* (kesemutan)
- b. *Parese* (kelemahan pada bagian otot tertentu), dan gangguan pergerakan.
- c. Hilang atau lemahnya refleks tendon
- d. Kesulitan menelan (*disfagia*)
- e. Gangguan komunikasi atau sulit memahami perkataan orang lain (afasia)
- f. Gangguan sensorik
- g. Gangguan fungsi kognitif dan psikologis
- h. Disfungsi kandung kemih
- i. Gangguan penglihatan pada salah satu atau kedua mata
- j. Gangguan keseimbangan dan gerak tubuh

8. Penanganan Stroke Iskemik: Langkah Cepat yang Menyelamatkan Otak

Stroke iskemik adalah kondisi medis yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan penanganan. Prinsipnya sederhana: semakin cepat ditangani, semakin banyak jaringan otak yang bisa diselamatkan. Menurut Kemenkes (2019) Penatalaksanaan stroke iskemik dibedakan menjadi fase hiperakut dan fase akut.

a. Fase Hiperakut

Pasien ini dikatakan hiperakut apabila datang dalam jangka waktu 6 jam setelah serangan. Tujuan dari tatalaksana pada fase hiperakut adalah untuk mengurangi tingkat *disabilitas* dan *mortalitas*.

Pendekatan multidisiplin pada fase hiperakut dimulai dari manajemen pra-rumah sakit dan rumah sakit.

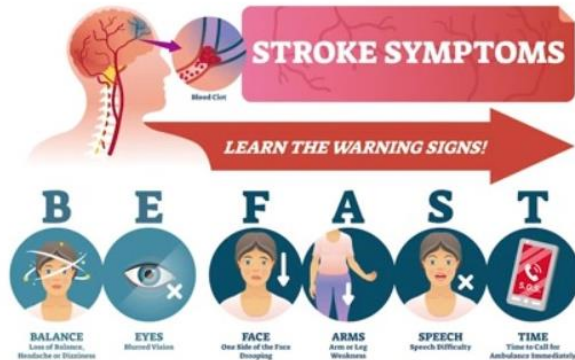
1) Manajemen pra-rumah sakit

Manajemen pra-rumah sakit dimulai dari keluhan yang dinyatakan oleh pasien dan keluarga serta petugas kesehatan di luar rumah sakit yang memahami tanda dan gejala stroke secara cepat dan benar. Keterlambatan dalam penilaian dan pengobatan stroke menentukan hasil akhir bagi pasien. Keluarga dan petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan awal dengan metode BEFAST (*Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time*). BEFAST adalah alat skrining sederhana yang digunakan untuk mengenali tanda-tanda awal seseorang terkena stroke, dimana:

- a) *Balance* (keseimbangan): apakah seseorang tiba-tiba mengalami kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, merasa pusing, atau kesulitan berjalan.
- b) *Eyes* (penglihatan): ada gangguan penglihatan, seperti penglihatan kabur, ganda, atau kehilangan penglihatan pada satu atau kedua mata.
- c) *Face* (wajah): kelumpuhan pada satu sisi wajah yang dapat menyebabkan posisi wajah miring atau sulit untuk menggerakkan bibir.
- d) *Arm* (Tangan): Pasien mungkin tidak dapat menggerakkan lengan dengan mudah

- e) *Speech* (pengucapan): berbicara pelan dan cenderung tidak jelas, cadel atau tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat
- f) *Time* (waktu): jika ada gejala tersebut segera bawa ke rumah sakit.

Jika ditemukan tanda-tanda tersebut harus segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan dengan prinsip "*Time is brain*" dan "*the golden hour*". *Golden period* merujuk pada periode waktu yang sangat penting setelah seseorang mengalami stroke. Waktu yang tepat untuk *golden period* bervariasi tergantung dari berbagai faktor tetapi umumnya trombolisis dapat dilakukan dalam waktu 4,5 jam setelah onsite gejala stroke.



Gambar 2.4 Penilaian Tanda-Tanda Stroke

2) Manajemen stroke di Rumah Sakit

Pada tahap intra rumah sakit, penanganan yang dilakukan pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki aliran darah ke otak (*reperfusi*), mencegah terjadinya *thrombosis* berulang, tatalaksana dari ruangan gawat darurat,

tatalaksana ruang perawatan stroke dan pemberian terapi spesifik stroke iskemik hiperakut. Pemeriksaan yang dilakukan pada stroke saat di rumah sakit yaitu:

- a) CT Scan Kepala untuk mendeteksi kerusakan otak, membedakan jenis stroke sebagai pertimbangan pemberian terapi trombolitik dan melihat adanya edema otak.
- b) MRI Brain untuk mengevaluasi, mendiagnosis, dan memantau kondisi medis terkait dengan kerusakan otak akibat stroke. MRI lebih sensitif untuk deteksi dini stroke iskemik dan gambaran detail struktur otak.
- c) *Echocardiografi* untuk mendeteksi sumber gumpalan darah di jantung yang dapat menjadi penyebab emboli.
- d) Pemeriksaan laboratorium darah, untuk mengetahui kadar gula darah, kecepatan pembekuan darah, kolesterol.
- e) USG karotis, untuk mendeteksi aterosklerosis di arteri besar leher (arteri karotis).
- f) *Elektrokardiografi*, untuk memeriksa irama jantung dan mendeteksi penyakit jantung atau aritmia.

b. Perawatan fase akut pada stroke iskemik

Tatalaksana stroke disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing pasien. Beberapa yang menjadi poin penting dalam tatalaksana tersebut yaitu:

1) Pemberian obat-obatan

- a) Pemberian obat anti hipertensi dan obat kolesterol untuk menjaga tekanan darah dalam batas normal dan mencegah berkembangnya aterosklerosis.



Gambar 2.5 Obat Anti Hipertensi



Gambar 2.6 Obat Kolesterol

- b) Obat untuk mengontrol kadar gula darah untuk pengelolaan kondisi hiperglikemi dan hipoglikemi.
- c) Pemberian terapi trombolisis dengan rtPA (*recombinant tissue plasminogen activator*).

rtPA merupakan pengobatan farmakologis untuk stroke iskemik akut. diberikan melalui infus pada onset 3-4,5 jam setelah gejala pertama muncul. Tujuannya untuk mempertahankan jaringan di area yang perfusinya menurun, mencegah



Gambar 2.7 Obat Trombolisis Intravena

kerusakan jaringan otak yang lebih luas akibat stroke. Pemberian rTPA dilakukan setelah ada hasil CT scan otak tidak ada perdarahan, diberikan dengan cepat, dan harus dengan

pemantauan ketat untuk mencegah efek samping dari obat.

d) Obat Antikoagulan

Antikoagulan diberikan pada stroke iskemik akut untuk mencegah gumpalan darah baru sehingga dapat menyebabkan stroke berulang. Pemberian harus hati-hati dan sesuai dengan pedoman terapi antokoagulan pada stroke iskemik. Berikut contoh obat antikoagulan yang dapat diberikan pada penderita stroke iskemik.



Gambar 2.8 Antikoagulan Injeksi



Gambar 2.9 Antikoagulan Oral

e) Obat Antiplatelet

Pemberian antiplatelet harus memperhatikan indikasi, manfaat dan risikonya. Untuk mencegah risiko stroke iskemik sekunder, dapat dipertimbangkan terapi pertama dengan dua antiplatelet yaitu aspirin dan *clopidogrel*. Pemberian antiplatelet dimulai 48 jam sejak dinyatakan stroke iskemik.

f) Pemberian osmotik deuretik



Gambar 2.10
Cairan Osmotik Deuretik

Penurunan tekanan intrakranial yang cepat dapat dicapai dengan pemberian diuretik. Diuretik yang umum digunakan selain furosemide yaitu manitol. Pasien dengan stroke iskemik dapat mengalami edema serebri sehingga dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intracranial. Pemberian terapi manitol untuk mengatasi edema cerebri.

2) Pembedahan

Pembedahan yang dilakukan pada stroke iskemik bertujuan untuk mengatasi penyumbatan yang mengganggu aliran darah ke otak. Tindakan ini sebagai tindakan *life saving* untuk mengatasi peningkatan intrakranial namun tindakan bedah dapat menimbulkan gejala sisa gangguan neurologik berat.

3) *Ventriculostomy* atau bedah dekompresi: dapat direkomendasikan sebagai terapi hidrosefalus obstruktif pada infark sereberal besar yang menekan batang otak dengan mempertimbangkan luas infark, kondisi neurologis, penekanan batang otak dan penggunaan obat.

4) Nutrisi

Pemberian makanan enteral harus dimulai dalam waktu 48 jam untuk menghindari katabolisme protein dan malnutrisi. Sebelumnya harus dilakukan penilaian fungsi bicara dan reflek menelan, jika diperlukan dapat dilakukan pemasangan selang nasogastrik pasang selang untuk pemberian nutrisi enteral.

c. Fase pemulihan stroke iskemik

Stroke iskemik memerlukan perawatan jangka panjang tergantung tingkat keparahannya dan bagian otak yang cidera. Beberapa terapi pada fase pemulihan yaitu:

1) Fisioterapi



Gambar 2.11
Rehabilitasi Paska Stroke

Tujuan fisiterapi untuk mengembalikan fungsi fisiologis pasien yang terganggu akibat stroke. Latihan untuk meningkatkan kekuatan otot yang mengalami kelumpuhan, termasuk otot-otot menelan, melatih keseimbangan pada saat berdiri, duduk dan berjalan, serta koordinasi tubuh pada saat menggerakkan tubuh. Latihan diawali dengan latihan sederhana seperti mengambil dan memegang benda, kemudian latihan akan dilanjutkan secara bertahap dan konsisten.

2) Terapi Okupasi

Terapi okupasi adalah jenis terapi yang dilakukan pada pasien stroke untuk mengembalikan kemandirian fungsional, kognitif, sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Terapi okupasi berperan penting dalam penanganan kasus stroke dengan memberikan beberapa intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi ekstremitas atas, keseimbangan, mobilitas, serta mengembalikan kepercayaan diri seseorang.

Terapi okupasi sebaiknya dilakukan secara dini, semakin cepat dilakukan semakin besar kemungkinan peningkatan atau pemulihan fungsional. Beberapa intervensi yang diberikan kepada pasien stroke mencakup latihan sederhana seperti memegang benda, menggunakan alat bantu, hingga melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, dan beraktivitas di rumah, keterampilan yang dibutuhkan untuk belajar atau bekerja, latihan sesuai dengan hobi, seperti bermain musik, melukis, melakukan kerajinan tangan, atau berolahraga, latihan untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, latihan untuk berbicara atau berkomunikasi, modifikasi alat-alat yang diperlukan di rumah atau tempat kerja, dan penggunaan alat bantu medis seperti kursi roda. Melalui terapi okupasi pasien akan dilatih untuk beradaptasi dengan kondisi fisik atau penyakit yang dialaminya

penderita stroke dapat meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam sebuah analisis dikatakan okupasi terapi dilakukan dengan berbagai jenis intervensi tambahan seperti *co-careldopa treatment*, *Physical Therapy*, *Prism adaptation training*, dan *Mirror Therapy*, dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup pasien pasca stroke. Studi ini menyimpulkan bahwa terapi okupasi dalam kombinasi dapat meningkatkan hasil rehabilitasi pasca stroke, termasuk kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dan fungsi motorik. Penelitian yang dilakukan oleh Gidion et.al (2022) mengatakan terapi okupasi bersumber pada Masyarakat pada pasien stroke dengan intervensi latihan stretching dan exercise guna penguatan otot dan peningkatan ROM serta pemberian modifikasi alat bantu berupa talenan, memiliki efektivitas terapeutik yang signifikan terhadap kemampuan dalam melakukan aktivitas dan meningkatkan kepuasan pada pasien stroke.



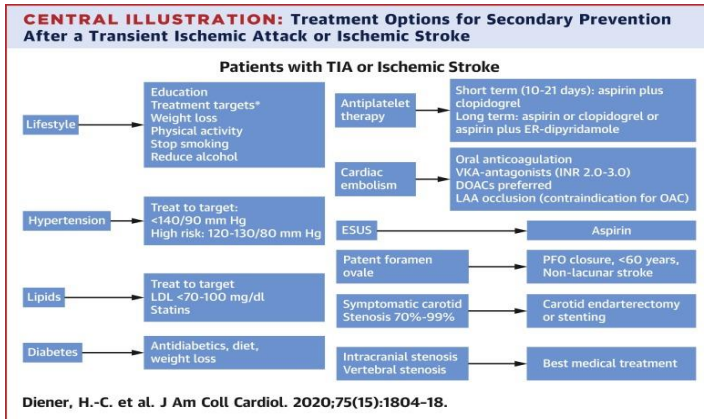
Gambar 2.12 Okupasi

3) Terapi bicara

Kesulitan bicara merupakan salah satu komplikasi umum pada stroke. Kerusakan otak yang disebabkan oleh iskemik dapat menyebabkan gangguan bicara yang disebut dengan *afasia*. Ada tiga jenis afasia yaitu afasia motorik, sensorik dan afasia global. Terapi bicara atau *speech therapy* adalah tindakan penanganan kesehatan yang dilakukan untuk individu dengan gangguan bicara, bahasa dan gangguan menelan. Tujuan terapi ini untuk mengembalikan kemampuan bicara dan komunikasi pasca stroke. Terapi ini mencakup latihan otot-otot lidah, cara mengucapkan kata-kata dan memahami dan menggunakan bahasa.

9. Mencegah Stroke Iskemik: Langkah Kecil untuk Hasil Besar

Untuk pencegahan primer dan pencegahan sekunder perlu mengontrol faktor risiko utama seperti tekanan darah, kolesterol, diabetes, dan berhenti merokok. Selain itu penderita harus menjaga berat badan ideal, olahraga teratur, menerapkan pola makan sehat, kontrol ke dokter secara rutin, minum obat secara teratur, mengendalikan stres serta mengenal tanda-tanda stroke.



Gambar 2.13 Ilustrasi Pusat (Central Illustration)

10. Komplikasi Stroke Iskemik: Dampak yang Perlu Diwaspadai

Komplikasi pada stroke iskemik bisa terjadi ringan sampai berat, bersifat sementara atau permanen, tergantung pada ukuran stroke dan bagian otak yang cedera. Komplikasi yang dapat terjadi pada klien dengan stroke iskemik antara lain: (34)

- Deep Vein Thrombosis** (thrombosis vena dalam)
Trombosis terbentuk pada kaki yang lumpuh menyebabkan penimbunan cairan dan pembengkakan (edema).
- Dekubitus atau luka tekan**
Luka tekan disebabkan terlalu lama baring di tempat tidur. Tingkat keparahan luka dapat bervariasi, mulai dari kemerahan ringan hingga luka dalam yang menjalar hingga ke tulang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko infeksi.
- Pneumonia**

Kondisi ini disebabkan penderita stroke tidak bisa batuk dan menelan dengan baik, ketidakmampuan bergerak akibat stroke sehingga cairan menumpuk di paru-paru dan menyebabkan pneumonia.

d. Atrofi dan kekakuan sendi.

Atrofi dapat disebabkan karena kurang gerak dan imobilisasi.

e. Infeksi saluran Kemih (ISK)

Kondisi ini dapat terjadi akibat pemasangan kateter dalam jangka waktu lama dan urin yang statis saat penyintas stroke tidak dapat mengontrol fungsi kandung kemih.

11. Merawat Pasien Stroke Di Rumah: Langkah Sederhana, Hasil Maksimal

Setelah melewati fase kritis di rumah sakit, pasien stroke masih perlu perawatan lanjutan di rumah. Merawat pasien stroke di rumah bukan hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga mencegah komplikasi lanjutan. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan keluarga:

a. Bantuan mobilisasi

Stroke dengan manifestasi kelemahan ekstremitas dapat meningkatkan risiko jatuh. Peran keluarga adalah membantu pasien beraktivitas dan menyediakan alat bantu mobilisasi sesuai dengan kebutuhan pasien seperti tongkat, tripot atau walker sesuai kebutuhan dengan pengawasan.

- b. Memotivasi latihan fisik dengan teratur
Mengajak pasien untuk melakukan latihan rentang gerak sendi secara teratur tiga kali sehari, termasuk pada bagian tubuh yang lemah, guna mencegah kekakuan dan meningkatkan kekuatan otot.
- c. Membantu proses makan
Pada awal serangan, penting sekali dilakukan skrining dysphagia untuk memastikan kemampuan menelan pasien. Bila hasil skrining dysphagia positif, pasien tidak diperbolehkan makan peroral dan pemberian nutrisi dilakukan melalui selang nasogastrik. Namun bila hasil skrining negative, pasien dapat diberikan makan peroral. Untuk mencegah aspirasi, berikan posisi pasien fowler atau setengah duduk pada saat makan. Perhatikan konsistensi makanan yang aman untuk dikonsumsi pasien sesuai dengan tingkat keparahan stroke yang dialami.
- d. Melakukan stimulasi komunikasi
Mengajak pasien bicara secara rutin agar pasien dapat kembali berkomunikasi dengan lancar.
- e. Melatih stimulasi kognitif
Memberikan stimulasi mental, seperti mengingat hari, waktu, dan mengingat nama orang-orang terdekat, untuk menjaga fungsi kognitif. Dengan demikian, sel-sel di dalam otak akan bekerja aktif, dan cara ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien.

- f. Menciptakan lingkungan yang aman
- Sesuaikan lingkungan dengan derajat keparahan stroke pasien. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien untuk mengurangi risiko cedera. Posisikan tempat tidur agar tidak terlalu tinggi dan meletakkan benda-benda yang dibutuhkan dalam jangkauan pasien. Pastikan area kamar mandi menggunakan pelapis lantai yang tidak licin, agar pasien tidak mudah terpeleset atau terjatuh. Pasang rel penyangga di sepanjang dinding, terutama di kamar mandi bila memungkinkan. Dengan bantuan penyangga pasien dapat berpegangan saat jalan menuju tempat yang diinginkannya sehingga dapat terhindar dari terjatuh. Dengan alat penyangga ini dapat membuatnya pasien lebih mandiri.
- g. Membantu pasien dalam pengelolaan obat
- Pastikan pasien mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Keluarga dapat menggunakan kotak obat atau pengingat di ponsel untuk membantu mempermudah manajemen obat dan memastikan tidak ada obat yang terlupa untuk diminum setiap harinya.
- h. Pemantauan kesehatan rutin
- Pasien stroke harus menjalani perawatan jangka panjang, untuk itu pasien harus rutin kontrol ke dokter atau ke klinik rehabilitasi medis. Rehabilitasi fisioterapi sangat penting untuk melatih kemampuan gerak, wicara, menelan, dan berpikir untuk membantu mengembalikan fungsi-fungsi fisik dengan lebih cepat. Pasien difasilitasi menggunakan

pengingat bila jadwal kontrol bila perlu menggunakan pengingat

- i. Menciptakan sistem panggilan bantuan di rumah
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, dapat menggunakan bel khusus yang dapat digunakan pasien. Dengan begitu, anggota keluarga yang tinggal serumah bisa mengetahui bahwa pasien sedang membutuhkan bantuan. Hal ini juga menjadi cara cepat bagi pasien untuk memanggil bantuan bila diperlukan.
- j. Memberikan dukungan emosional dengan terus menemani pasien.

Selain masalah fisik, kondisi mental dan psikologis pasien juga perlu diperhatikan. Kondisi stroke dapat membuat seseorang ketergantungan terhadap orang lain sehingga membuat kemandirian pasien menurun, pasien juga merasa kesepian dan terabaikan. Hal ini dapat memicu terjadinya kondisi depresi dan memperlambat proses pemulihan.



Gambar 2.14 Dukungan Emosional

k. Kenali tanda-tanda stroke berulang.

Tanda-tanda stroke berulang sama dengan gejala pada saat serangan pertama. Gunakan metode “BEFAST” untuk memastikan pasien dapat segera mendapatkan penanganan medis. Beberapa tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya stroke berulang yaitu:

- 1) Pengelolaan faktor risiko vaskular untuk pencegahan stroke sekunder, terutama pada penderita diabetes, hipertensi, berhenti merokok dan hiperlipidemia.
- 2) Merubah gaya hidup, termasuk pola makan sehat, diet rendah garam, aktivitas fisik yang aman dan kepatuhan pengobatan.
- 3) Pemeriksaan diagnostik setelah stroke iskemik, untuk menentukan etiologi stroke iskemik dan mengidentifikasi target pengobatan guna mengurangi risiko stroke iskemik berulang. Rekomendasi sekarang dikelompokkan berdasarkan subtype etiologi.
- 4) Mengubah perilaku pasien melalui program edukasi dengan dukungan multidisiplin.
- 5) Terapi antitrombotik, termasuk agen antiplatelet atau antikoagulan, kombinasi antiplatelet dan antikoagulasi biasanya tidak diindikasikan untuk pencegahan stroke sekunder
- 6) Pemantauan irama jantung untuk fibrilasi atrium okultisme biasanya direkomendasikan jika tidak ditemukan penyebab stroke.

7) Penanganan adanya stenosis arteri karotis dapat dilakukan pemasangan stent arteri karotis. Pasien dengan stenosis intrakranial berat di daerah vaskular akibat stroke iskemik sementara tidak boleh dilakukan angioplasti dan pemasangan stent sebagai terapi lini pertama untuk mencegah kekambuhan.

I. Penanganan kejang

Pasien stroke memiliki risiko tinggi mengalami kejang karena adanya jaringan otak yang rusak. Stroke adalah cedera neurologis yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya arteri di otak dan menyebabkan kerusakan jaringan di otak, hal itu dapat mengganggu aliran aktivitas listrik antara sel-sel saraf dan menyebabkan kejang. Beberapa risiko yang dapat menyebabkan kejang pada pasien stroke tergantung jenis stroke, tingkat keparahan stroke dan area otak yang cidera. Jika mendapatkan pasien kejang tindakan yang harus dilakukan adalah:

- 1) Baringkan tubuh penderita di tempat aman
- 2) Jangan menahan tubuh pasien
- 3) Singkirkan benda berbahaya di sekitar penderita untuk mencegah terjadinya cedera selama kejang
- 4) Jangan memasukkan benda apapun (sendok, kain, handuk) ke dalam mulut penderita
- 5) Jika kejang sudah berhenti, posisikan dalam posisi nyaman dan jangan berikan makan atau minum hingga kembali sadar penuh.
- 6) Catat durasi dan frekuensi kejang

7) Segera bawa penderita ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan optimal.

m. Penanganan penurunan kesadaran

Penurunan kesadaran pada pasien stroke merupakan kondisi darurat. Prinsip penanganannya menjaga jalan napas, mencegah cedera, dan segera menghubungi tenaga medis untuk mempercepat penanganan dan mencegah komplikasi. Tindakan yang harus dilakukan pada pasien penurunan kesadaran yaitu: menilai tingkat kesadaran, memeriksa nadi dan pernafasan, jika terjadi henti jantung lakukan RJP jika mampu, posisikan pasien miring (posisi pemulihan), jangan berikan makanan dan minuman, segera hubungi layanan gawat darurat.

B. Status Neurologis: Mengukur Fungsi Sistem Saraf Pasien Stroke

1. Apa itu Status Neurologis?

Status neurologis merupakan kondisi yang mendeskripsikan fungsi sistem saraf seseorang, meliputi fungsi motorik, sensorik, kognitif dan otonom yang dievaluasi secara sistematis menggunakan metode klinis dan diagnostik. Menurut *American Association of Neuroscience Nurses* (AANN, 2020), status neurologis adalah hasil dari evaluasi terintegrasi terhadap fungsi otak, saraf tulang belakang, dan saraf perifer. Menilai status neurologis untuk mengukur tingkat kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh penyakit seperti

stroke, cedera kepala, atau penyakit neurodegenerative. Untuk menilai seberapa serius kondisi seseorang setelah terkena stroke, tim medis menggunakan alat ukur bernama *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS). NIHSS adalah skala medis yang menilai kemungkinan stroke iskemik akan menyebabkan defisit neurologis. Skornya berkisar antara 0 dan 42, dan skor yang lebih tinggi menunjukkan defisit neurologis yang lebih parah. Hasil fungsional jangka panjang setelah stroke dapat diprediksi dengan baik oleh nilai prognostik yang kuat dari NIHSS awal. Skala NIHSS untuk menilai tingkat keparahan stroke serta menentukan respon terhadap terapi trombolisis dan dinilai dalam 24 jam serangan stroke atau 5 hari sampai 7 hari perawatan.

2. Menentukan Derajat Kerusakan Neurologis

Beberapa faktor yang berhubungan dengan derajat kerusakan neurologis yaitu Jenis kerusakan dan lokasi cedera, waktu penanganan, dan faktor lain seperti gaya hidup, kondisi medis seperti tekanan darah yang tinggi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stress, hiperglikemia yang berlangsung lama yang akan mempercepat terjadinya aterosklerosis pembuluh darah besar dan kecil, hiperkolesterol dengan nilai kolesterol >200 mg/dl akan memicu terjadinya stroke, obesitas yang dapat dilihat dari Indeks Massa Tubuh (IMT).

3. Penilaian dalam Skala *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS)

Skor NIHSS menilai kesadaran, gerakan mata, lapang pandang, gerakan wajah, kekuatan otot lengan dan tungkai, koordinasi, sensorik, bahasa, bicara, serta hilang

atau kurangnya perhatian. Item tersebut dinilai dengan skala ordinal dan dijumlahkan dengan total skor antara 0–42. Derajat NIHSS diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan yaitu: NIHSS < 5: Stroke ringan, NIHSS 5–15: Stroke sedang, NIHSS 16–20: Stroke sedang hingga berat, NIHSS 21–42: Stroke berat.

C. Kualitas Hidup (*Quality of Life*)

1. Definisi Kualitas Hidup

Kualitas hidup menurut *World Health Organization Quality of Life* atau WHOQOL didefinisikan sebagai persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan dalam kaitannya dengan konteks budaya dan nilai di mana seseorang tinggal, serta tujuan, harapan, standar, dan kekhawatirannya. Dalam konteks sehat, kualitas hidup adalah suatu kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial individu terbebas dari berbagai kelemahan dan penyakit.

2. Elemen Kualitas Hidup

Aspek umum dari kualitas hidup meliputi kesehatan pribadi (fisik, mental, dan spiritual), hubungan, status pendidikan, lingkungan kerja, status sosial, kekayaan, rasa aman dan terlindungi, kebebasan, otonomi dalam pengambilan keputusan, rasa memiliki secara sosial, dan lingkungan fisik. Untuk menilai kualitas hidup seseorang, ada empat domain, masing-masing dengan beberapa dimensi, menurut WHO penilaian dengan kuisioner WHOQOL-BREF mencakup empat domain mencakup kesehatan fisik, Kesehatan psikologis/mental, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Hidup Pasien Stroke

Kualitas hidup pasien stroke dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisik maupun psikologis. Menurut Abdu et.al (2022) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidupn pasien stroke yaitu:

a. Faktor fisik dan mental

Dilihat dari tingkat disabilitas, komplikasi medis, kemampuan fungsional, serta tingkat depresi dan persepsi diri. Semakin berat stroke yang dialami maka dampak yang ditimbulkan semakin berat baik secara fisik maupun kognitif. Depresi pasca stroke dapat mempengaruhi motivasi pasien dalam menjalani rehabilitasi sehingga akan mempengaruhi proses penyembuhan dan menurunkan kualitas hidup.

b. Faktor komorbiditas

Penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit kardiovaskular mempengaruhi kualitas hidup pasien stroke dan dapat memperburuk prognosis penyakit tersebut. Jumlah komorbiditas yang lebih besar dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan ketergantungan fisik dan gangguan kognitif.

c. Faktor sosial

Pasien stroke membutuhkan dukungan dari keluarga dan hubungan sosial yang baik. Perhatian anggota keluarga memiliki dampak positif pada pemulihan dan kualitas hidup. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial dapat membuat seseorang merasa lebih memiliki dan lebih baik secara emosional.

d. Faktor ekonomi

Pengeluaran biaya untuk pengobatan dan rehabilitasi bisa menjadi beban finansial yang signifikan. Sementara dengan kejadian stroke seseorang akan kehilangan pekerjaan atau kemampuan untuk bekerja, hal ini sering kali memengaruhi stabilitas finansial keluarga.

e. Faktor lingkungan

Kurangnya akses terhadap pelayanan rehabilitasi oleh tenaga kesehatan, khususnya rehabilitasi berbasis rumah seperti terapi fisik dan okupasi terapi, serta kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan rehabilitasi stroke. Hal merupakan masalah sistemik yang harus ditekankan dan direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Rumah atau lingkungan yang ramah disabilitas mempengaruhi kemampuan pasien untuk hidup mandiri.

f. Faktor spiritual dan budaya

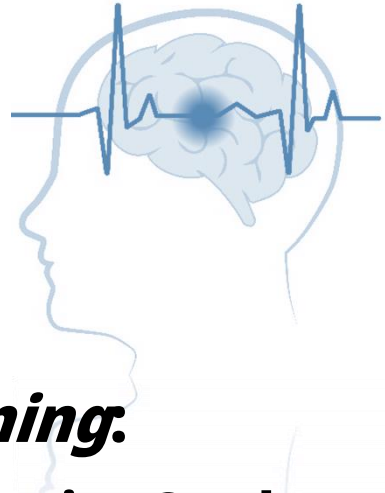
Keyakinan atau praktik agama sering kali memberikan dukungan emosional dan cara pasien beradaptasi dipengaruhi oleh cara keluarga dan masyarakat melihat disabilitas mereka.

g. Efektifitas *Discharge Planning* dan Rehabilitasi

Beberapa penelitian tentang efektifitas rencana pemulangan terstruktur yang melibatkan pasien dan keluarga terbukti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi risiko readmisi, menurunkan *Length of Stay* (LOS). *Discharge planning* yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga secara aktif dalam proses perawatan dapat meningkatkan

pengetahuan pasien dan keluarga. Keikutsertaan aktif pasien dalam aktivitas rehabilitasi dapat meningkatkan kemandirian pasien stroke secara bertahap.

BAB 3



Konsep

Discharge Planning.

Persiapan Pulang Pasien Stroke

A. Apa itu *Discharge Planning*?

D *ischarge Planning* atau perencanaan pemulangan adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pasien mulai dari pasien masuk ke rumah sakit melalui pendekatan interdisipliner, bekerja sama dengan pasien dan keluarga untuk membantu pasien dan keluarganya mendapatkan pemahaman, meningkatkan keterampilan, mengatasi masalah kesehatan, membantu proses penyembuhan dan mencegah kemungkinan terjadi komplikasi.

Discharge planning merupakan bagian integral dalam asuhan keperawatan komprehensif. Proses ini tidak hanya berfokus pada penanganan kondisi klinis selama perawatan di rumah sakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan perencanaan perawatan lanjutan setelah pasien kembali ke lingkungan rumah. Tujuan utamanya adalah memastikan

kontinuitas perawatan yang optimal, meminimalkan risiko komplikasi, serta mendukung adaptasi pasien dan keluarga terhadap perubahan yang terjadi paska-stroke. Pendekatan multidisipliner dalam *discharge planning* telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke.

Sebuah tinjauan sistematis oleh Rosadi dan Arofiati (2024) mengatakan bahwa intervensi edukatif, baik melalui media cetak maupun digital, serta pendekatan keperawatan yang berpusat pada keluarga, dapat meningkatkan fungsi fisiologis, pengetahuan kognitif, dan kepuasan pasien, serta mengurangi risiko komplikasi dan rehospitalisasi.

B. Tujuan *Discharge Planning*

Discharge planning dilakukan dengan beberapa tujuan penting, yaitu:

1. Membantu keluarga dalam proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan baik secara fisik, psikologis dan sosial meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga.
2. Memastikan perawatan yang berkelanjutan saat pasien sudah pulang ke rumah.
3. Mengurangi risiko perawatan kembali dan terjadinya komplikasi akibat ketidakmampuan pasien dan keluarga.
4. Membantu dalam sistem pelayanan rujukan jika diperlukan.
5. Membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien.
6. Memberikan informasi pada pasien dan keluarga sesuai kebutuhan mereka baik secara tertulis maupun secara verbal.

C. Mengapa *Discharge Planning* Penting?

Beberapa manfaat dari *Discharge planning* yaitu dapat mengurangi pelayanan yang tidak terencana (*unplanned admission*), mengantisipasi terjadinya kegawatdaruratan setelah kembali ke rumah (*readmission*), mengurangi LOS (*Length Of Stay*) di rumah sakit, meningkatkan kepuasan individu dan pemberi layanan, menghemat biaya selama proses perawatan hingga perawatan di rumah atau di masyarakat serta hasil kesehatan yang dicapai menjadi optimal. Beberapa penelitian menyatakan *discharge planning* memiliki peranan penting dalam menurunkan komplikasi, mencegah stroke berulang serta menurunkan angka mortalitas dan morbiditas.

D. Faktor -faktor yang Memengaruhi *Discharge Planning*

Pelaksanaan *discharge planning* yang efektif dan komprehensif sangat diperlukan bagi pasien untuk memastikan kontinuitas perawatan setelah keluar dari rumah sakit dan mencegah terjadinya komplikasi. Namun keberhasilan dalam implementasinya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *discharge planning* berasal dari perawat dan pasien, faktor yang berhubungan dengan perawat yaitu:

1. Cara penyampaian informasi kepada pasien
2. Pengendalian emosi
3. Pengetahuan perawat
4. Pengalaman perawat

Sedangkan faktor yang berasal dari pasien yaitu:

1. Motivasi
2. Sikap positif dalam menerima diagnose penyakit
3. Emosi
4. Kesehatan fisik
5. Usia
6. Kemampuan dalam proses belajar

Perawat memiliki peranan penting dalam proses pemulangan pasien. Partisipasi aktif dan komunikasi yang efektif dari semua personil baik tim kesehatan maupun keluarga sangat diperlukan dalam proses *discharge planning*. Selain faktor-faktor tersebut, waktu, cara edukasi dan koordinasi interdisipliner serta memperhatikan kondisi kesehatan pasien, lingkungan sosial dan sumber daya yang tersedia menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan discharge planning.

E. Prinsip Penting dalam *Discharge Planning*

Prinsip yang diterapkan dalam *discharge planning* adalah perencanaan dibuat dari mulai pasien masuk, berfokus pada kebutuhan pasien, melibatkan keluarga atau *care giver*, dan dokumentasi pelaksanaan, oleh karena itu dibutuhkan identifikasi kebutuhan pasien pada saat pasien pulang nanti, sehingga kemungkinan masalah yang timbul saat di rumah dapat diantisipasi, perencanaan dilakukan pada semua sistem kesehatan dengan kolaborasi antar multidisiplin serta menyesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang ada.

F. Elemen dalam *Discharge planning*

Perencanaan pulang yang efektif adalah dengan melibatkan pasien dan keluarga, kolaborasi antara tim kesehatan, dukungan dari *care giver*/pendamping pasien dan kesiapan komunitas/keluarga dalam menerima pasien kembali ke rumah. Komponen dalam *discharge planning* yaitu:

1. Pengkajian awal yang komprehensif
Meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kebutuhan rehabilitasi pasien untuk menentukan rencana perawatan yang sesuai.
2. Edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga
Edukasi yang diberikan mengenai konsep penyakit, kondisi kesehatan, pengobatan, perubahan gaya hidup, perubahan aktivitas, latihan, diet makanan yang dianjurkan dan pembatasannya, cara perawatan diri dan mengenal tanda-tanda kegawatan yang memerlukan bantuan medis
3. Rencana rehabilitasi
Proses rehabilitasi pasien stroke meliputi terapi fisik, okupasi, dan wicara untuk memaksimalkan pemulihan fungsi fisik pasien.
4. Pengelolaan obat
Membuat jadwal pemberian obat yang jelas dan memastikan pasien serta keluarga memahami dosis, frekuensi, dan tujuan penggunaan obat. Daftar nama obat harus mencakup nama, dosis, frekuensi, dan efek samping yang umum terjadi.
5. Penjelasan tentang prosedur pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lain.
6. Perawatan atau pengobatan selanjutnya setelah pasien pulang

7. Perawatan untuk mencegah komplikasi
8. Mengatur perawatan lanjutan (jadwal pelayanan di rumah, perawat yang menjenguk, penolong, pembantu jalan/walker, kanul oksigen, dan lain-lain)

G. Peran Perawat dalam *Discharge Planning*

Discharge planning merupakan proses penting dari asuhan keperawatan komprehensif yang bertujuan untuk memastikan kelanjutan perawatan pasien setelah keluar dari rumah sakit, meningkatkan kualitas perawatan, mengidentifikasi kebutuhan perawatan di rumah untuk memberikan kesinambungan perawatan. Perawat memiliki peranan penting dalam perawatan pasien stroke yang efisien dan efektif untuk mengoptimalkan hasil bagi penyintas stroke dan keluarga. Seorang perawat harus menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk mempersiapkan penyintas stroke dan keluarga dalam manajemen diri, rehabilitasi, dan pemulihan pasca keluar dari rumah sakit.

Seorang perawat baik perawat primer maupun katim harus terlibat dalam perencanaan pemulangan. Dengan melaksanakan peran dan tanggung jawab secara optimal, perawat dapat membantu meningkatkan pengetahuan, peningkatan ADL, peningkatan kualitas hidup, mengurangi angka *readmisi*, meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi risiko komplikasi dan memastikan kelangsungan perawatan yang berkualitas setelah pasien keluar dari rumah sakit. *Rehospitalisasi* pasien stroke menjadi salah satu indikator keberhasilan *discharge planning*. Untuk mencegah *rehospitalisasi* atau *readmisi* perawat memberikan edukasi

secara komprehensif, memberikan dukungan social dan memastikan kontinuitas perawatan melalui perencanaan pemulangan. Dalam konteks pasien stroke, perawat memegang peran sentral dalam merancang dan melaksanakan *discharge planning* yang efektif. Berikut adalah peran-peran utama perawat dalam proses *discharge planning*:

1. *Assessor*

Dalam *discharge planning* perawat memiliki peranan penting dalam membuat perencanaan. Peran ini tidak hanya pada penilaian kondisi fisik pasien, tetapi juga mencakup identifikasi kebutuhan perawatan jangka panjang, baik secara medis maupun psikososial. Perawat berperan aktif dalam mengevaluasi kebutuhan pasien dan sumberdaya dan sistem dukungan sosial yang diperlukan untuk memastikan perawatan yang baik setelah di rumah. Penilaian yang komprehensif memungkinkan perawat untuk merancang rencana pemulangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

2. *Edukator*

Perawat memberikan edukasi tentang penyakit, rencana perawatan lanjutan setelah keluar dari rumah sakit, rencana pengobatan, nutrisi, cara perawatan diri secara mandiri dan upaya pencegahan stroke berulang. Sebagai edukator perawat harus mempersiapkan materi edukasi, memiliki pengetahuan yang cukup dan komunikasi yang baik agar dapat melakukan perencanaan pemulangan terstruktur dan efektif.

3. *Kolaborator*

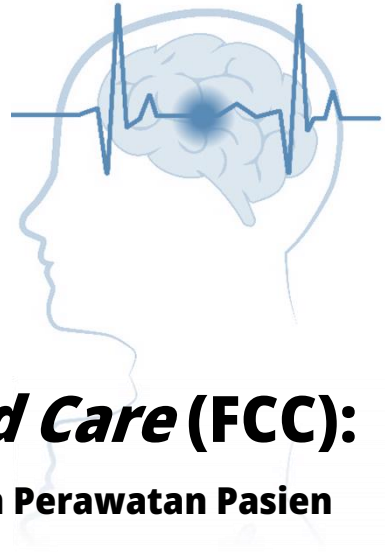
Perawat bekerja sama interdisipliner yaitu dengan medis, ahli gizi, fisioterapis untuk memastikan perencanaan

pemulangan yang komprehensif, jika diperlukan perawat dapat berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan lain untuk memastikan kesinambungan perawatan.

4. *Fasilitator*

Perawat membantu pasien dan keluarga dalam mempersiapkan kebutuhan untuk pemulangan seperti obat, alat bantu dan lain-lain, mengevaluasi pemahaman pasien dan keluarga tentang rencana perawatan di rumah dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Perawat juga melakukan pemantauan kondisi pasien setelah pemulangan untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana perawatan dan mendeteksi dini komplikasi.

BAB 4



Konsep

Family Centered Care (FCC):

Merangkul Keluarga dalam Perawatan Pasien

A. Apa itu *Family Centered Care*?

Keluarga adalah unit/lembaga/sistem sosial terkecil dalam suatu masyarakat dan terdiri dari sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga berdasarkan hubungan kekerabatan seperti perkawinan, pertalian darah dan adopsi. *Family Centered Care (FCC)* adalah pendekatan yang holistik dan inovatif dalam menetapkan strategi pemberian perawatan yang berkualitas dan meningkatkan hubungan profesional antara perawat, pasien, dan keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan klinis. Menurut *Association for the Care of Children's Health (ACCH)* *Family Centered Care* didefinisikan sebagai filosofi dimana perawatan yang diberikan kepada pasien harus melibatkan keluarga sebagai pendukung dalam membantu membuat keputusan yang terbaik selama sakit hingga proses penyembuhan. Perawatan yang berpusat pada keluarga pada pasien stroke dapat meningkatkan kualitas hidup pasien stroke.

B. Tujuan *Family Centered Care*

Tujuan dilakukan perawatan berbasis keluarga adalah untuk menjalin kerjasama antara keluarga dan petugas pelayanan kesehatan, memberdayakan keluarga sebagai sistem yang terlibat dalam perawatan baik saat di rumah sakit sampai perawatan di rumah. Penerapan FCC pada pasien stroke dapat meningkatkan efektifitas rehabilitasi dan kualitas perawatan yang diberikan. FCC juga membantu pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik keluarga yang merawat pasien stroke, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang optimal.

C. Prinsip *Family Centered Care* yang Wajib Diterapkan

1. Menghormati dan menghargai keluarga dengan mengakui bahwa keluarga berperan penting dalam kehidupan pasien dan menghormati nilai, kepercayaan, serta pilihan mereka dalam perawatan.
2. Berbagi informasi yaitu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami keluarga mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, dan perkembangan yang terjadi.
3. Partisipasi yaitu mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif keluarga dalam perawatan pasien, termasuk aktivitas sehari-hari dan pengambilan keputusan.
4. Kolaborasi yaitu petugas kesehatan bekerja sama dengan keluarga dalam merencanakan perawatan, melakukan tindakan keperawatan dan mengevaluasi untuk memastikan kebutuhan serta preferensi pasien terpenuhi.

D. Peran Keluarga dalam Perawatan Pasien Stroke

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan luas dalam mendampingi pasien stroke, tidak hanya dalam hal perawatan fisik, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional dan sosial. Dukungan, pemahaman dan keterlibatan aktif keluarga akan sangat membantu proses pemulihan pasien mulai dari rehabilitasi fisik, pencegahan stroke berulang dan pencegahan komplikasi yang mungkin terjadi. Selain itu, keluarga juga menjadi sumber motivasi utama bagi pasien demi kesehatannya. Dengan perhatian dan kepedulian, keluarga turut membantu menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi pasien untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih berkualitas.

E. Peran Perawat dan Keluarga dalam *Family Centered Care*

Perawatan yang berpusat pada keluarga adalah model perawatan kesehatan yang mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan terkait perencanaan, pemberian, dan evaluasi perawatan kesehatan. Proses pemulangan pasien secara komprehensif melibatkan semua pemberi layanan kesehatan, pasien dan keluarga. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan memiliki peran penting dalam proses *discharge planning* yaitu sebagai *educator, collaborator dan conselor*. Hal ini sesuai dengan tugas utama perawat dalam *discharge planning* yaitu melakukan pengkajian kebutuhan pasien, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, koordinasi /kolaborasi dengan sistem layanan kesehatan, penyedia informasi tertulis melalui *discharge planning* dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut.

F. Integrasi *Family Centered Care* dalam *Discharge Planning* untuk Pasien Stroke

Stroke merupakan penyebab utama kecacatan yang didapat pada usia dewasa dan termasuk dalam kelompok penyakit serebrovaskular dengan dampak yang luas terhadap aspek kesehatan dan sosial. Dampak ini tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya angka prevalensi dan insidensi, melainkan juga oleh konsekuensi yang ditimbulkannya, terutama dalam hal ketergantungan pasien serta implikasinya terhadap kualitas hidup pasien dan keluarga. Stroke menyebabkan gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan motorik, kognitif, dan emosional pasien. Penilaian status neurologis bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan atau gangguan dalam sistem saraf sentral & perifer, mengukur tingkat keparahan stroke yang implikasinya pada prognosis, tingkat kecacatan dan proses pengobatan.

Pemulihan setelah stroke tidak hanya bergantung pada terapi medis, tetapi juga pada intervensi keperawatan melalui keterlibatan aktif keluarga atau pengasuh dalam proses perawatan berkelanjutan. Dengan melibatkan keluarga dalam perencanaan pulang dapat menghasilkan outcome yang baik pada pasien stroke. *Family-Centered Care* (FCC) adalah pendekatan holistik yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perawatan pasien, termasuk dalam proses *discharge planning*.

Implikasi dalam meningkatkan fungsi neurologis dan kualitas hidup pada pasien stroke dengan penerapan *discharge planning* berbasis FCC memungkinkan stimulasi kognitif dan

motorik berkelanjutan di rumah, karena keluarga dibekali pengetahuan dan keterampilan perawatan paska-stroke, pencegahan komplikasi melalui pengawasan lebih intensif oleh keluarga serta dukungan emosional yang kuat, yang terbukti mempercepat pemulihan neurologis dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam meningkatkan kualitas hidup pada pasien stroke iskemik diperlukan pendekatan yang holistik dalam aspek keperawatan, beberapa mekanisme yang diterapkan adalah:

1. Dukungan tenaga kesehatan

Kebutuhan informasi kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh keluarga atau *care giver*. Petugas kesehatan harus memberikan dukungan secara profesional melalui edukasi kesehatan terstruktur dan komprehensif mencakup cara perawatan pasca stroke termasuk langkah-langkah rehabilitasi. keluarga dapat diberikan leaflet tentang perawatan pasien stroke. Tingkat pengetahuan keluarga atau *care giver* dan keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien dapat meningkatkan motivasi dan kualitas hidup pasien stroke.

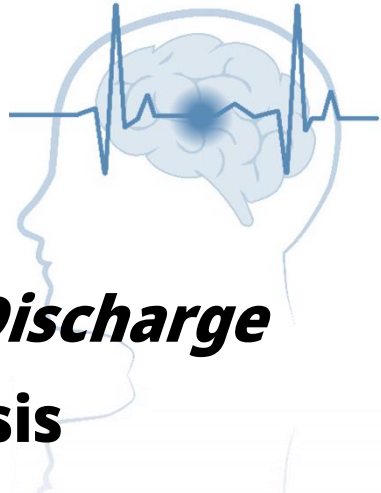
2. Dukungan emosional

Dukungan emosional dari keluarga merupakan hal yang sangat penting pada pasien stroke. Dukungan emosional dapat memberikan rasa aman dan nyaman dan dapat membantu mengurangi tingkat stres pada pasien stroke iskemik. Petugas kesehatan harus memberikan edukasi kepada keluarga agar dapat memberikan dukungan terhadap keluarga pasca stroke untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pasien pasca stroke. Selain

dukungan keluarga dibutuhkan dukungan komunitas untuk memberi dukungan kepada pasien dan keluarga selama proses perawatan.

3. Bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari
Pasien stroke mengalami defisit neurologis sehingga membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari seperti pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, kebersihan diri dan mobilisasi. Peran keluarga sebagai *caregiver* utama sangat signifikan dalam perawatan pasien stroke. Dengan melibatkan keluarga secara aktif dalam perawatan sehari-hari pasien dapat membantu mencegah komplikasi dan mempercepat proses rehabilitasi. Keluarga juga dapat terlibat dalam mengelola pengobatan dan mendampingi pasien dalam menjalani terapi serta memastikan kepatuhan terhadap rencana perawatan.
4. Perawatan berkelanjutan
Perawatan berkelanjutan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang konsisten dan terkoordinasi dari berbagai profesional kesehatan. Hal ini mencakup komunikasi yang efektif antara dokter, perawat, terapis, dan anggota keluarga untuk memastikan bahwa semua aspek perawatan pasien terpenuhi. Pendekatan perawatan yang holistik dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau terminal.

BAB 5



Implementasi *Discharge Planning* Berbasis *Family Centered Care* (FCC)

D *ischarge planning berbasis Family-Centered Care* (FCC) pada pasien stroke merupakan pendekatan yang melibatkan keluarga secara aktif dalam proses perencanaan pemulangan pasien dari rumah sakit ke rumah. Tujuannya adalah untuk memastikan transisi yang aman, efektif, dan mendukung pemulihan pasien di lingkungan rumah dengan dukungan keluarga yang optimal. Model FCC diterapkan melalui penerapan sistem kolaboratif yang berfokus pada kekuatan dan sumber daya keluarga, mengakui keahlian keluarga dalam perawatan pasien, membangun rasa kepemilikan dibandingkan ketergantungan, dan meningkatkan komunikasi antara pasien, keluarga, perawat, dan layanan kesehatan. Implementasinya *discharge planning* berbasis FCC memberikan edukasi yang mudah dipahami keluarga sehingga serta mengembangkan rencana perawatan bersama keluarga (64). Implementasi ini harus terdokumentasi pada catatan perawat dengan lengkap dari assesmen awal hingga pasien pulang.

Berikut tahapan dalam discharge planning berbasis FCC:

A. Tahapan Dalam *Discharge Planning* Berbasis FCC

1. Tahap Awal (*assessment*)

Pada tahap awal dilakukan segera setelah pasien dirawat. Perawat atau tim kesehatan melakukan pengkajian dengan melibatkan pasien dan keluarga. Pengkajian meliputi pengkajian fisik, kognitif, dan emosional pasien, menilai pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan di rumah dan mengidentifikasi kebutuhan khusus seperti penggunaan alat bantu dan terapi lanjutan. Penilaian kondisi neurologis dan fungsional pasien yaitu dengan menggunakan skor *National Institute of Health Scale* (NIHSS) skala kualitas hidup dengan menggunakan *Stroke Specific Quality of Life Scale* (SS-QOL). Selain itu perawat juga menilai kebutuhan lainnya yaitu pendidikan kesehatan pasien dan keluarga yang berhubungan dengan perawatan di rumah dan bagaimana mencegah terjadinya komplikasi. Tindakan ini untuk melihat tingkat kemandirian pasien setelah keluar dari rumah sakit serta mengevaluasi dukungan yang tersedia dalam keluarga, termasuk partisipasi anggota keluarga dalam perawatan, mengetahui sumber daya yang dimiliki, serta kesiapan keluarga dalam merawat pasien pasca stroke.

2. Membuat Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan dibuat berdasarkan hasil pengkajian yang menggambarkan masalah kesehatan pasien. Diagnosis keperawatan dapat membantu membuat intervensi yang tepat dan tujuan yang relevan untuk mendukung pemulihan pasien dan kesiapan keluarga dalam merawat di rumah.

Tujuan yang akan dicapai adalah pemahaman pasien dan keluarga terkait masalah kesehatan dan implikasinya, pasien akan mampu memenuhi kebutuhan individualnya, lingkungan rumah menjadi aman dan tersedia sumber perawatan kesehatan di rumah.

Diagnosa keperawatan pada pasien stroke berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu:

Tabel 5.1 Diagnosa Keperawatan pada Pasien Stroke (SDKI)

No	Diagnosa Keperawatan	Definisi
1	Penurunan kapasitas Adaptif intracranial	Gangguan mekanisme dinamika intracranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intracranial
2	Risiko Perfusi cerebral tidak efektif	Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak
3	Gangguan mobilitas fisik	Keterbatasan dalam Gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri
4	Gangguan komunikasi verbal	Penurunan, perlambatan atau ketiadaan kemampuan untuk menerima, memproses, mengirim, dan/atau menggunakan sistem simbol
5	Gangguan menelan	Fungsi menelan abnormal akibat deficit struktur atau fungsi oral, faring atau esofagus
6	Risiko Aspirasi	Berisiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkhial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas

7	Nyeri akut	Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan
8	Risiko gangguan integritas kulit dan jaringan	Berisiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) atau jaringan (membrane, mukosa, krtilago kapsul sendi dan/atau ligamen)
9	Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan	Pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari yang cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan

3. Menyusun Rencana Keperawatan

Menyusun rencana perawatan yang komprehensif melibatkan multidisipliner keluarga secara aktif. Perencanaan mencakup rencana perawatan, nutrisi, rehabilitasi fisik, okupasi dan terapi bicara, obat-obatan yang diperlukan, tindakan pencegahan terjadinya komplikasi pasca stroke, serta manajemen faktor risiko untuk mencegah stroke berulang. Perencanaan juga mencakup aspek psikososial guna memastikan pasien mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari keluarga dan lingkungan.

4. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi fokus pada pemberian edukasi kesehatan dan pendokumentasian, melibatkan tim multidisiplin dalam proses *discharge planning* melalui komunikasi efektif antar anggota tim, pasien dan keluarga. Edukasi merupakan komponen penting dalam *discharge*

planning berbasis FCC, diberikan kepada pasien dan keluarga berdasarkan kebutuhan pasien. Edukasi menggunakan media pamflet atau dengan video berbasis aplikasi, edukasi dapat dilakukan saat perawatan dan saat pasien akan pulang. Pada hari kepulangan pasien, petugas kesehatan memberikan kesempatan pasien dan keluarga untuk berdiskusi tentang hal yang berkaitan dengan perawatan di rumah, memastikan obat-obatan sudah sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan edukasi yaitu:

- a. Keluarga harus diberikan pemahaman tentang teknik perawatan dasar seperti cara membantu mobilisasi, cara memberi makan, serta bagaimana mengelola kebersihan pasien dan pencegahan komplikasi
- b. Keterlibatan keluarga dalam manajemen pengobatan dan kebutuhan rehabilitasi
- c. Optimalisasi kehadiran keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke
- d. Manajemen nutrisi pentingnya asupan gizi yang seimbang bagi pasien stroke.
- e. Memastikan keamanan bagi pasien setelah di rumah untuk mengurangi risiko cedera.

Keluarga juga perlu memastikan lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi pasien. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan posisi tempat tidur agar tidak terlalu tinggi serta memastikan benda-benda penting berada dalam jangkauan pasien. Area kamar mandi juga

harus diperhatikan dengan memasang pelapis lantai yang tidak licin guna mengurangi risiko terpeleset atau jatuh. Pemasangan rel penyangga di sepanjang dinding, terutama di kamar mandi, sangat dianjurkan agar pasien dapat berpegangan saat berjalan. Hal ini akan membantu meningkatkan kemandirian pasien.

5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pasien dipulangkan, tim kesehatan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perawatan di rumah berjalan sesuai rencana. *Follow-up* dapat dilakukan melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau melalui konsultasi jarak jauh (*telehealth*). Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa keluarga tetap mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dan rencana perawatan dapat disesuaikan jika diperlukan sesuai dengan perkembangan kondisi pasien.

B. Manfaat Implementasi *Family Centered Care* untuk Pasien Stroke

Implementasi *discharge planning* berbasis *Family-Centered Care* (FCC) pada pasien stroke memberikan berbagai manfaat signifikan yang berdampak positif pada proses pemulihan pasien dan kesiapan keluarga dalam merawat di rumah, tidak hanya meningkatkan hasil klinis pasien tetapi juga memberdayakan keluarga dalam proses perawatan. Melalui edukasi, dukungan, dan kolaborasi yang efektif, pendekatan ini menciptakan lingkungan perawatan yang holistik dan berpusat pada kebutuhan pasien dan keluarganya. Menurut beberapa

penelitian manfaat implementasi FCC dalam perawatan stroke adalah:

1. Membantu pasien dan keluarga dalam proses pemulihan dari rumah sakit.
2. Meningkatkan kesiapan pasien dalam mengelola manajemen pengobatan dan aktivitas sehari-hari.
3. Mengurangi tingkat stress dan kecemasan keluarga.
4. Membantu keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan pasien.
5. Menurunkan angka rawat kembali ke rumah sakit.
6. Membantu meningkatkan kualitas hidup.

C. Pemantauan Perawatan Pasca Stroke Di Rumah

Untuk mengetahui perkembangan pasien selama perawatan di rumah, keluarga dapat membuat pemantauan harian meliputi:

1. Laporan Ceklist Harian

Tabel 5.2 Ceklist Harian Perawatan Di Rumah

Hari	Minum obat tepat waktu	Latihan fisik	Pola Makan sehat	Tekanan darah	kontrol dokter	Keluhan yang dirasakan	Catatan tambahan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2. Catatan Perkembangan Kesehatan

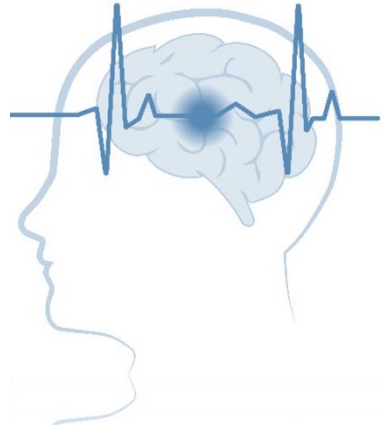
Tabel 5.3 Catatan Perkembangan Kesehatan

Hari	Kekuatan tangan dan kaki	Kemampuan Komunikasi	Fungsi Menelan	Kemandirian dalam beraktivitas	Eliminasi BAB/BAK	Keseimbangan tubuh	Emosi dan perilaku
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Petunjuk Pengisian:

1. Kekuatan tangan dan kaki: catat kekuatan menggenggam, mengangkat tangan, kekuatan kaki.
2. Komunikasi: perhatikan kemampuan bicara dan bagaimana pasien memahami percakapan.
3. Menelan: perhatikan kemampuan menelan makanan / minuman.
4. Kemandirian aktivitas sehari-hari: Catat bagaimana kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berpindah tempat, berpakaian dan menjaga keseimbangan.
5. BAB/BAK: monitor kontrol buang air dan frekuensinya.
6. Keseimbangan: perhatikan apakah pasien dapat duduk atau berdiri secara mandiri.
7. Emosi dan perilaku: amati apakah ada emosi dan perilaku yang tidak seperti biasa.

BAB 6



Kesimpulan

Discharge planning berbasis *Family Centered Care* (FCC) merupakan pendekatan holistik dan kolaboratif yang menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam perawatan pasien stroke iskemik. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada proses pemulangan pasien secara administratif, tetapi juga mencakup persiapan fisik, psikologis, edukatif, dan lingkungan untuk memastikan kesinambungan perawatan di rumah. Melalui keterlibatan aktif keluarga sejak awal perawatan hingga pasca pemulangan, *discharge planning* berbasis FCC terbukti mampu meningkatkan status neurologis pasien, mencegah komplikasi, mengurangi risiko rehospitalisasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien stroke iskemik. Peran perawat dalam proses ini sangat krusial, baik sebagai edukator, kolaborator, maupun fasilitator yang memastikan perawatan berkelanjutan berjalan optimal.

Dengan adanya buku ini, diharapkan tenaga kesehatan memiliki panduan praktis dan terstruktur dalam menyusun dan mengimplementasikan discharge planning berbasis FCC, serta memberdayakan keluarga agar mampu memberikan dukungan optimal dalam proses pemulihan pasien stroke iskemik.

Standar Prosedur Operasional (SPO)
Pelaksanaan *Discharge Planning*

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) <i>DISCHARGE PLANNING</i> BERBASIS FCC PADA PASIEN STROKE ISKEMIK	
Pengertian	Proses perencanaan pemulangan pasien dari rumah sakit ke rumah yang dilakukan secara terstruktur mencakup identifikasi kebutuhan, edukasi, koordinasi untuk memastikan kontinuitas perawatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien stroke dengan melibatkan pasien dan keluarga secara aktif, dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi perawatan pasien.
Tujuan	1. Menjamin kesinambungan perawatan pasien stroke iskemik dari rumah sakit ke lingkungan rumah dengan melibatkan keluarga. 2. Mempersiapkan keluarga dalam merawat pasien di rumah 3. Meningkatkan kualitas perawatan dan hasil klinis pasien, 4. Meningkatkan status neurologis dan kualitas hidup pasien stroke iskemik melalui edukasi terstruktur dan dukungan keluarga
Kebijakan	1. <i>Discharge planning</i> dilakukan sejak pasien masuk rumah sakit hingga pasien dipulangkan. 2. Keluarga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap <i>discharge planning</i>. 3. Edukasi diberikan kepada pasien dan keluarga mengenai perawatan pasca-stroke, termasuk pencegahan komplikasi dan rehabilitasi.
Petugas	Perawat dan tim kesehatan lainnya
Peralatan	1. Alat tulis 2. Modul 3. Lembar observasi
Prosedur	A. Persiapan 1. Petugas memperkenalkan diri 2. Identifikasi Pasien dan Keluarga a. Melakukan pengkajian awal terhadap kondisi medis pasien, kemampuan fungsional, status

	neurologis, kebutuhan psikososial dan dukungan keluarga b. Mengidentifikasi peran dan kesiapan keluarga dalam perawatan pasien. c. Memberikan informasi kepada keluarga mengenai rencana perawatan, prognosis, dan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perawatan B. Pelaksanaan 1. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai konsep penyakit stroke, penggunaan obat dan kepatuhan terhadap terapi, perawatan dan pencegahan komplikasi, tanda-tanda peringatan stroke berulang, latihan fisik dan terapi rehabilitasi, 2. Melatih keluarga dalam keterampilan perawatan dasar, seperti membantu mobilisasi, perawatan luka, dan penggunaan alat bantu. 3. Melibatkan tim multidisiplin (dokter, perawat, fisioterapis) dalam perencanaan pemulangan. C. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut 1. Menilai kesiapan pasien dan keluarga untuk pemulangan, kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan. 2. Menyusun rencana pemulangan yang mencakup jadwal kontrol dan terapi lanjutan, rujukan ke layanan home care atau komunitas dukungan jika ada, kontak darurat dan informasi penting lainnya. 3. Mendokumentasikan seluruh proses <i>discharge planning</i> dalam rekam medis pasien. D. Melakukan evaluasi lanjutan Melakukan <i>follow-up</i> melalui telepon atau kunjungan rumah untuk memastikan perawatan lanjutan.
Referensi	• Pengaruh <i>Discharge Planning</i> dengan Pendekatan Family Centered Nursing Terhadap Kualitas Hidup pasien Stroke (Milya Novera, 2023) • Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1

**Formulir Perencanaan Pemulangan
Pasien Stroke Berbasis Family Centered Care (FCC)**

1. Informasi Umum Pasien

Nama pasien :
Nomor rekam medis :
Tanggal masuk RS :
Rencana pulang :
Diagnosa medis :
Diagnosa keperawatan :
Skor NIHSS awal :
Skor NIHSS saat pulang :
Skala *SS-QOL* saat masuk :

2. Data Keluarga

Nama penanggungjawab :
Hubungan dengan pasien :
Nomor kontak :
Alamat :

3. Identifikasi Kebutuhan dan Kesiapan Pasien & Keluarga

a. Kebutuhan fisik

- ☐ Mobilitas (alat bantu: tongkat, kursi roda)
- ☐ Perawatan luka
- ☐ Terapi okupasi/fisioterapi
- ☐ Bantuan aktivitas sehari-hari (mandi, berpakaian, makan)

b. Kebutuhan Psikososial

- ☐ Dukungan emosional
- ☐ Konseling keluarga
- ☐ Informasi tentang komunitas dukungan stroke

c. Kebutuhan edukasi

- ☐ Penggunaan obat
- ☐ Tanda dan gejala peringatan stroke
- ☐ Jadwal kontrol dan rehabilitasi
- ☐ Nutrisi dan diet pasca-stroke

d. Kesiapan keluarga

- ☐ Memahami cara perawatan dasar
- ☐ Memahami jadwal pengobatan
- ☐ Mengetahui cara menangani situasi darurat
- ☐ Siap menyediakan lingkungan rumah yang aman

4. Diagnosa Keperawatan

- ☐ Penurunan kapasitas adaptif intrakranial
- ☐ Risiko perfusi cerebral tidak efektif
- ☐ Gangguan mobilitas fisik
- ☐ Gangguan menelan
- ☐ Risiko aspirasi
- ☐ Nyeri akut
- ☐ Risiko gangguan integritas kulit

5. Rencana Edukasi

- a. Mengajarkan latihan fisik tentang keseimbangan dan penguatan otot kepada pasien dan keluarga untuk dilakukan secara rutin di rumah.
- b. Memberikan pelatihan kepada keluarga tentang penggunaan terapi sensorik auditori yang dapat meningkatkan fungsi neurologis pasien.
- c. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya mengelola kondisi kesehatan lain seperti hipertensi dan diabetes untuk mencegah kekambuhan stroke.
- d. Mengedukasi tentang tanda-tanda peringatan stroke dan langkah-langkah pencegahan, termasuk perubahan gaya hidup sehat dan kepatuhan terhadap pengobatan.
- e. Menyediakan informasi tentang kelompok dukungan dan layanan konseling untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi stres dan depresi yang mungkin timbul pasca-stroke.

6. Implementasi

- a. Tanggal edukasi :
- b. Metode edukasi :
 - ☐ Tatap muka
 - ☐ Brosur/leaflet
 - ☐ Video edukasi
 - ☐ Demonstrasi langsung

c. Partisipasi keluarga

- ☐ Aktif dalam sesi edukasi
- ☐ Menunjukkan pemahaman melalui tanya jawab
- ☐ Mampu melakukan demonstrasi ulang perawatan dasar
- ☐ Lain-lain:.....

7. Evaluasi dan Tindak Lanjut

a. Evaluasi Pemahaman:

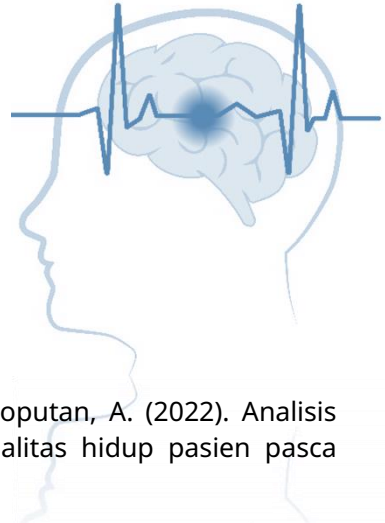
- ☐ Pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali informasi yang diberikan.
- ☐ Demonstrasi ulang perawatan dilakukan dengan benar.

b. Rencana Tindak Lanjut:

- 1) Kontrol ke Dokter: Tanggal _____, Poli

- 2) Terapi Lanjutan:
 - ☐ Fisioterapi
 - ☐ Terapi Wicara
 - ☐ Terapi Okupasi
- 3) Kunjungan Homecare: Ya /Tidak

Daftar Pustaka



- Abdu, S., Satti, Y. C., Payung, F., & Soputan, A. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien pasca stroke. *2022*, 5(2), 50–59.
- Abdul Gofur. (n.d.). *Tata laksana stroke dan penyakit vaskuler lain* (3rd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Adinda Fadilah, & Tuti Pahria, N. N. (2025). Kombinasi pemberian terapi okupasi pasien pasca stroke: A scoping review. *Heal Malahayati Journal, Student*, 5, 126–147. Retrieved from <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/MAHESA/article/view/16363/0>
- Afriani, J., Zakiyah, V., Azriliyani, R., & Rahmawati, Y. (2024). Tata laksana terapi stroke hemoragik pada hipertensi. *2024*, 2(3), 32–36.
- Agusman, F., Mendrofa, M., Iswanti, D. I., Moh, I. M., & Saifudin, Y. (2025). The role of family-centered care in enhancing stroke rehabilitation outcomes: An integrative literature review. *2025*, 14(2), 1031–1039.
- Akbar, M. A., Juniarti, N., & Yamin, A. (2021). Intervensi perawatan pasien stroke selama di rumah: Systematic review. *2021*(July).
- Al-mahdi, F., Negara, C. K., Basid, A., & Dalle, J. (2025). Family centered nursing care (FCN) model in SNH (non-hemorrhagic stroke) patients. *2025*, 13(01), 212–220.

- Appelros, P., Matérne, M., Jarl, G., & Arvidsson-Lindvall, M. (2021). Comorbidity in stroke-survivors: Prevalence and associations with functional outcomes and health. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 30(10). Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106000>
- Arianti, D., Novera, M., & Restipa, L. (2019). Pengaruh discharge planning dengan pendekatan family centered nursing terhadap kualitas hidup pasien stroke. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 2(2), 11–18.
- Arif, M., Okraini, N., Yuliano, A., & Putra, M. (2019). Hubungan ketepatan "golden period" dengan derajat kerusakan neurologi pada pasien stroke iskemik di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2018. *2019*, 2(1), 94–98.
- Ariya, S. K. N. (2021). *Merawat pasien pascastroke di rumah*. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Arsyi, R. N. (2024). Occupational therapy in stroke: A case study using the Bobath frame of reference and task oriented approach. *Jurnal Fisioterapi Terapan Indonesia*, 3(1).
- Avan, A., Digaleh, H., Di Napoli, M., Stranges, S., Behrouz, R., & Shojaeianbabaei, G. (2019). Socioeconomic status and stroke incidence, prevalence, mortality, and worldwide burden: An ecological analysis from the Global Burden of Disease Study 2017. *2019*.
- Azzubaidi, S. B. S., Rachman, M. E., & Hamado, N. (2024). Gambaran kualitas hidup berdasarkan karakteristik pada pasien pasca stroke. *2024*, 5, 2511–2517.
- Błaż, M. (2023). Family history of stroke – a useful clue for the primary care physician and stroke neurologist: A narrative review. *2023*, 32(1), 31–39.

- Camicia, M., Lutz, B., Summers, D., Klassman, L., & Vaughn, S. (2021). Nursing's role in successful stroke care transitions across the continuum: From acute care into the community. *Stroke*, 52(12), E794–E805.
- Chalos, V., Van Der Ende, N. A. M., Lingsma, H. F., Mulder, M. J. H. L., Venema, E., Dijkland, S. A., et al. (2020). National Institutes of Health Stroke Scale: An alternative primary outcome measure for trials of acute stroke. *2020*, 282–290.
- Cockroft, K. M., Gutierrez, J., Lombardi-Hill, D., Kamel, H., Meschia, J. F., & Nguyen, T. N., et al. (2021). 2021 Guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack.
- Darussalam, M., Shaluhiah, Z., & Widjanarko, B. (2022). Stroke rehabilitation program in improving ADL (Activity Daily Living): Literature review. *2022*, 7(4), 1067–1074.
- Darussalam, M., & Nugraheni, S. A. (2021). Peningkatan kualitas hidup pada pasien stroke pada fase rehabilitasi: Literature review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 4, 867–878. Retrieved from <https://journal.ppnijateng.org/index.php/jiki>
- Deisi, V., Sumakul, O., Karouw, B. M., & Pongantung, H. (2024). The influence of family-centered care against quality life of stroke patient at home in Tomohon City Indonesia. *2024*, 3(8), 3513–3526.
- Fan, J. L., Brassard, P., Rickards, C. A., Nogueira, R. C., Nasr, N., & McBryde, F. D., et al. (2021). Integrative cerebral blood flow regulation in ischemic stroke.
- Feigin, V. L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S., Sacco, R. L., & Hacke, W., et al. (2022). World Stroke Organization (WSO): Global stroke fact sheet 2022. *International Journal of Stroke*, 17(1), 18–29.
- Fitrina, Y., Andriani, M., & Sari, G. M. (2023). Faktor-faktor yang

berhubungan dengan pelaksanaan discharge planning di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 6. Retrieved from <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/meditory/article/view/2112>

Franziska, H., & Rincon, F. (2020). Management of acute ischemic stroke. *2020*, 48(11).

Gidion, H., Luthfi, M., & Setisari, D. D. (2022). Studi kasus penatalaksanaan terapi okupasi bersumberdaya masyarakat dalam aktivitas memasak pada penderita stroke di Desa Setisari. *Jurnal Fisioterapi Terapan Indonesia*, 1(1).

Hardika, B. D., Yuwono, M., & Zulkarnain, H. M. (2020). Faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya stroke non hemoragik pada pasien di RS RK Charitas dan RS Myria Palembang. *2020*, 9(2), 268–274.

Harianja, F. (2020). Optimalisasi pelaksanaan discharge planning secara terintegrasi di ruang rawat inap X RS Militer Jakarta. *KARS: The Journal of Hospital Accreditation*, 2. Retrieved from <http://web.kars.or.id/>

Harni, S. Y. (2024). *Peran keluarga dalam merawat lansia pasca stroke*. Putri R.B (Ed.). Eureka Media Aksara.

Hui, L. P. M. Z. K. S. C. (2024). *Ischemic stroke*. India: StatPearls Publishing.

Hurford, R., Muir, K. W., Sekhar, A., & Hughes, T. A. T. (2020). Diagnosis and management of acute ischaemic stroke. *2020*, 306–318.

Hutagalung, M. S. (2021). *Mengenal stroke dan karakteristik penderita stroke hemoragik dan non-hemoragik: Panduan lengkap stroke*. 2021.

- Hutagalung, M. S. (2021). *Stroke, kualitas hidup dan discharge planning: Panduan lengkap stroke*. Nusa Media.
- Ika, A., Rohmah, N., Rifayuna, D., Ilmu, F., Universitas, K., Malang, M., et al. (2021). Kebutuhan family caregiver pada pasien stroke. *2021*, 9(1), 143–152.
- Jehosua, W. A., Kakerissa, N., Pangaribuan, R. N., & Eka, N. G. A. (2023). Effect of an educational intervention program on discharge planning for nurses and midwives. *Enfermería Clínica*, 33, S33–S37. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862123000098>
- Kemenkes, P. (2024). Jenis-jenis stroke iskemik dan hemoragik. *Penyakit Tidak Menular Indonesia*. Retrieved from <https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/jenis-jenis-stroke-iskemik-dan-hemoragik>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana stroke*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Laely, A. J., Nursalam, N., & Effendy, F. (2023). Efektivitas discharge planning pasien stroke terhadap readmisi dan lama rawat: Tinjauan sistematis. *2023*, 9(1), 25–34.
- Lima, D. U. D., Moreira, R. P., Cavalcante, T. F., Gasparino, R. C., Cristina, S., & Emidio, D., et al. (2022). Assessment of neurological status in patients with cerebrovascular diseases through the nursing outcome classification: A methodological study. *2022*, 152–163.
- Lindsay, M. P., Norrving, B., Sacco, R. L., Brainin, M., Hacke, W., & Martins, S., et al. (2019). World Stroke Organization (WSO): Global stroke fact sheet 2019. *2019*, 14(8), 806–817.

- Lui, P. T. F. (2023). *Acute stroke*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/>
- Maita Sarah, S.Kep., Ns. M.K. (2023). *Pengembangan model Family Centered Care (FCC) bagi caregiver yang merawat pasien stroke di rumah* (Awahita, R., Ed.). Jawa Barat: Jejak.
- Martini, S., Amalia, D., Ningrum, S., Abdul-mumin, K. H., & Yi-li, C. (2022). Assessing quality of life and associated factors in post-stroke patients using the World Health Organization abbreviated generic quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF). *Clinical Epidemiology and Global Health*, 13, 100941. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100941>
- Mohtar, M. S. (2019). Hubungan durasi pertolongan dengan tingkat kerusakan neurologis pasien stroke di RSUD Ulin Banjarmasin. 2019, 10(1).
- Mugi Hartoyo, M., Arifin Hidayat, Ns., Ayu, S. A., Arisdiani, T., Netti, Ns., & Yuliasuti, R. A., et al. (2024). *Buku ajar keperawatan medikal bedah* (1st ed.). Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Mujib, M. I. R., & Arofiati, F. (2023). Development of discharge planning for stroke patients. *Folia Medica Indonesiana*, 59(4), 396–405.
- Muhawarman, A. (2024). Cegah stroke dengan aktivitas fisik. *Kemendes*. Retrieved from <https://kemendes.go.id/id/rilis-kesehatan/cegah-stroke-dengan-aktivitas-fisik>
- Murphy, S. J., & Werring, D. J. (2023). Stroke: Causes and clinical features. *Medicine (United Kingdom)*, 51, 602–607.
- Owolabi, M. O., Thrift, A. G., Mahal, A., Ishida, M., Martins, S., & Johnson, W. D., et al. (2022). Primary stroke prevention worldwide: Translating evidence into action. *Lancet Public Health*, 7(1), e74–e85.

- Patti, C. H., PT, & MZKS, L. (2024). *Stroke iskemik*. Treasure Island: StatPearls Publishing.
- Petersen, A. S. N. H. (2024). *Physiology, cerebral autoregulation*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- Rahayu, T. G. (2023). Analisis faktor risiko terjadinya stroke serta tipe stroke. *2023*, 10(1), 48–53.
- Retnaningsih, D. (2023). *Asuhan keperawatan pada pasien stroke* (M. Nasrudin, Ed.). Pekalongan, Indonesia: Nasya Expanding Management.
- Rofi'i, M. (2021). *Discharge planning pada pasien di rumah sakit*. 2021.
- Said Taha, A., & Ali Ibrahim, R. (2020). Effect of a design discharge planning program for stroke patients on their quality of life and activity of daily living. *International Journal of Studies in Nursing*, 5(1), 64.
- Seniwati, T., Rustina, Y., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2023). Patient and family-centered care for children: A concept analysis. *2023*, 9(1), 17–24.
- Sesrianty, N. V., Kairani, A., & Si, M. (2020). *Discharge planning (perencanaan pasien pulang) di rumah sakit*. Pena Persada.
- Sesrianty, N. V. (2022). *Discharge planning (perencanaan pasien pulang) di rumah sakit*. 2022.
- She, R., Yan, Z., Hao, Y., & Zhang, Z. (2022). Comorbidity in patients with first-ever ischemic stroke: Disease patterns and their associations with cognitive and physical function. *2022*, 15, 1–12.
- Soebagiyo, H., Beni, K. N., & Fibriola, T. N. (2019). Systematic review: The analysis of the influencing factors related to the effectiveness of discharge planning implementation in hospitals. *2019*, 14(3), 217–220.

- Wati, E. (2023). Pengaruh discharge planning berbasis keluarga terhadap kualitas hidup pasien stroke: Literatur review. *2023*, 2(2).
- World Health Organization. (2021). *WHOQOL: Mengukur kualitas hidup*. WHO.
- Wulandari, D. F., & Hariyati, R. T. (2019). Pelaksanaan discharge planning di ruang ICU RS X Jakarta. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 5(1), 67–76.
- Zhachrani, N. F., Muchsin, A. H., & Tammasesse, J. (2024). Relationship between family support and quality of life in stroke patients. *Journal La Medihealtico*, 5(04), 865–872.
- Zhuo, Y., Qu, Y., Wu, J., Huang, X., Yuan, W., & Lee, J., et al. (2021). Estimation of stroke severity with National Institutes of Health Stroke Scale grading and retinal features. *2021*, 0, 1–6.

Sinopsis

Buku ini merupakan panduan komprehensif mengenai implementasi discharge planning berbasis Family Centered Care (FCC) yang dikhususkan bagi pasien stroke iskemik. Penulis secara mendalam membahas tentang pentingnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses pemulangan pasien dari rumah sakit ke rumah untuk memastikan kesinambungan perawatan serta mempercepat pemulihan pasien.

Stroke iskemik sebagai penyebab utama disabilitas jangka panjang membutuhkan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya melibatkan perawat, tetapi juga keluarga sebagai mitra utama. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam perawatan stroke iskemik seperti konsep penyakit, faktor risiko, diagnosis, hingga penanganan medis dan rehabilitasi. Ditekankan juga bahwa implementasi discharge planning secara sistematis, terstruktur, dan berbasis keluarga dapat mengurangi komplikasi, rehospitalisasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pendekatan FCC yang dijelaskan dalam buku ini mencakup peran perawat sebagai edukator, kolaborator, dan fasilitator, serta pentingnya edukasi terstruktur kepada keluarga tentang perawatan sehari-hari, pencegahan komplikasi, pengelolaan obat-obatan, terapi rehabilitasi, dan monitoring di rumah. Buku ini dilengkapi dengan berbagai tabel, checklist harian, dan catatan perkembangan kesehatan yang praktis, menjadikannya alat bantu penting bagi tenaga kesehatan dan keluarga dalam menjalankan perawatan lanjutan di rumah.

Dengan mengintegrasikan konsep Family Centered Care secara efektif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, keluarga pasien, serta institusi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan pemulihan pasien stroke iskemik secara berkelanjutan.

Buku ini merupakan panduan komprehensif mengenai implementasi discharge planning berbasis Family Centered Care (FCC) yang dikhususkan bagi pasien stroke iskemik. Penulis secara mendalam membahas tentang pentingnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses pemulangan pasien dari rumah sakit ke rumah untuk memastikan kesinambungan perawatan serta mempercepat pemulihan pasien.

Stroke iskemik sebagai penyebab utama disabilitas jangka panjang membutuhkan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya melibatkan perawat, tetapi juga keluarga sebagai mitra utama. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam perawatan stroke iskemik seperti konsep penyakit, faktor risiko, diagnosis, hingga penanganan medis dan rehabilitasi. Ditekankan juga bahwa implementasi discharge planning secara sistematis, terstruktur, dan berbasis keluarga dapat mengurangi komplikasi, rehospitalisasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pendekatan FCC yang dijelaskan dalam buku ini mencakup peran perawat sebagai edukator, kolaborator, dan fasilitator, serta pentingnya edukasi terstruktur kepada keluarga tentang perawatan sehari-hari, pencegahan komplikasi, pengelolaan obat-obatan, terapi rehabilitasi, dan monitoring di rumah. Buku ini dilengkapi dengan berbagai tabel, checklist harian, dan catatan perkembangan kesehatan yang praktis, menjadikannya alat bantu penting bagi tenaga kesehatan dan keluarga dalam menjalankan perawatan lanjutan di rumah.

Dengan mengintegrasikan konsep Family Centered Care secara efektif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, keluarga pasien, serta institusi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan pemulihan pasien stroke iskemik secara berkelanjutan.

Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta